Perfil V3 · código por código

Oftalmología

Los 63 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Oftalmología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 31 códigos

6.02.1.001 Ametropía

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Ametropías: miopía (ojo largo, foco delante de la retina; mala visión de lejos y buena de cerca; lentes divergentes negativos), hipermetropía (ojo corto, foco detrás; astenopia acomodativa con cefalea frontal; lentes convergentes positivos; predispone a glaucoma agudo) y astigmatismo (córnea irregular, visión distorsionada de lejos y cerca; lentes cilíndricos).
- Sospecha: baja de agudeza visual, entrecerrar los ojos, acercarse a la pantalla o al libro, cefalea y fatiga ocular. La clave diagnóstica es el agujero estenopeico (1–1,5 mm): si la AV mejora es un vicio de refracción; si no mejora hay lesión orgánica (catarata, maculopatía, neuritis) o ambliopía.
- Presbicia: pérdida fisiológica de acomodación desde los 40–45 años (síndrome de los brazos cortos); se corrige con lentes positivos para cerca.
- Tratamiento inicial en APS: confirmar con tabla de Snellen y estenopeico, descartar causas orgánicas, y entregar o indicar corrección óptica según la prescripción; en niños, pesquisar ambliopía.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/optometría para refracción y receta de lentes; control anual en niños (la miopía alta predispone a desprendimiento de retina y glaucoma crónico).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 125

Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8 al mirar por un agujero estenopeico. No presenta dolor. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma
B) Estrabismo
C) Vicio de refracción
D) Catarata
E) Coriorretinitis

Respuesta C. La mejoría de la agudeza visual al mirar por un agujero estenopeico es característica de los vicios de refracción: el defecto es puramente óptico, no orgánico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 95

Un niño de 5 años, nacido a las 32 semanas por parto vaginal, es llevado a control porque se acerca mucho a la pantalla cuando ve televisión. La inspección ocular es normal. La agudeza visual es 20/25 en el ojo derecho y 20/80 en el ojo izquierdo, la cual mejora a 20/25 al usar un agujero estenopeico. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Ambliopía
B) Microftalmia
C) Ametropía
D) Glaucoma congénito
E) Retinopatía del prematuro

Respuesta C. La mejora de la agudeza visual al mirar a través de un agujero estenopeico es característica de los vicios de refracción, o ametropías. Aquí la agudeza visual se corrige por completo, así que no hay ambliopía; si solo hubiese mejorado en forma parcial, el diagnóstico habría incluido ambliopía anisometrópica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años consulta por dificultades para ver. Al examen físico destaca agudeza visual de 20/60, que cambia a 20/30, al mirar por un agujero estenopeico. La madre refiere que siempre se restriega los ojos. El diagnóstico más probable es:

A) Blefaritis
B) Conjuntivitis viral
C) Ametropía
D) Conjuntivitis bacteriana crónica
E) Glaucoma congénito

Respuesta C. Tiene una caída de la AV que mejora al mirar por un agujero estenopeico, así que tiene un vicio de refracción, también llamado ametropía. La AV pasó de 0,33 a 0,67, por lo que mejoró (se calcula con la simple división de 20/60 y 20/30).

6.02.1.002 Blefaritis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Blefaritis: inflamación crónica y bilateral del borde palpebral, asociada a dermatitis seborreica y rosácea; ardor, arenilla, prurito y costras al despertar. Anterior: escamas grasosas (seborreica) o collaretes duros (estafilocócica) en la base de las pestañas. Posterior: disfunción de glándulas de Meibomio con secreción espesa tipo «pasta de dientes» y ojo seco.
- Específico: diagnóstico clínico por inspección del borde con lupa; descartar chalazión recurrente, ojo seco y carcinoma sebáceo en cuadros unilaterales o asimétricos con pérdida de pestañas.
- Tratamiento completo: higiene palpebral diaria (compresas tibias previas y limpieza con champú de bebé neutro diluido o toallitas específicas), masaje del borde y lágrimas artificiales; es el pilar y va antes de cualquier colirio.
- Casos moderados o con rosácea: ungüento antibiótico (eritromicina o cloranfenicol) en el borde y doxiciclina oral 100 mg/día por 4–6 semanas. Corticoide tópico solo con indicación oftalmológica.
- Seguimiento completo: es crónica y recidivante, se controlan las recaídas; derivar si hay compromiso corneal, baja de visión o falta de respuesta.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años, con rosácea, consulta por ardor y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos de varios meses, peor al despertar. Al examen hay bordes palpebrales eritematosos y engrosados, con escamas adheridas a la base de las pestañas y orificios de las glándulas de Meibomio obstruidos. Agudeza visual normal. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Antibiótico oral por 7 días y alta
B) Drenaje quirúrgico de las glándulas de Meibomio
C) Colirio de corticoide de alta potencia en forma permanente
D) Derivación urgente a oftalmología
E) Higiene palpebral diaria con compresas tibias y masaje del borde palpebral, más lágrimas artificiales

Respuesta E. La blefaritis es una inflamación crónica del borde palpebral, asociada a dermatitis seborreica y rosácea. La base del tratamiento es la higiene palpebral diaria: compresas tibias, masaje y limpieza del borde, con lágrimas artificiales. En casos persistentes se agregan antibióticos tópicos, o doxiciclina oral en la disfunción de Meibomio.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina
B) Azitromicina
C) Aciclovir
D) Mupirocina
E) Dexametasona

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Aciclovir (opción C). Era un herpes periocular.. La queratitis herpética produce una úlcera dendrítica o en helecho, prácticamente patognomónica de herpes simple ocular, tratamiento con aciclovir tópico y oral. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

6.02.1.003 Catarata

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.8 Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

QUÉ HAY QUE SABER

- Catarata: opacificación del cristalino; senil en >90 % (nuclear: esclerosis amarillenta y miopización; cortical: opacidades en radios de rueda; subcapsular posterior: caída rápida y deslumbramiento diurno). Secundarias: corticoides (subcapsular posterior, incluso en jóvenes), diabetes, trauma (roseta), uveítis, congénita.
- Específico: baja de visión lenta, bilateral, indolora y sin ojo rojo; deslumbramiento al conducir de noche; «segunda visión» (el présbita vuelve a leer sin lentes). Confirmar con reflejo rojo pupilar con oftalmoscopio directo a 1 metro (atenuado o con manchas oscuras); una AV que no mejora con agujero estenopeico sugiere opacidad de medios.
- No existe tratamiento médico: ningún colirio previene ni revierte la catarata. En leucocoria en un niño descartar retinoblastoma y catarata congénita (derivación urgente).
- Tratamiento inicial: notificar GES catarata (nº 21; ojo con AV ≤0,3) y derivar para cirugía, que se indica por el impacto funcional (leer, conducir, riesgo de caídas) y no por «madurez»; técnica de elección facoemulsificación con lente intraocular, ambulatoria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; corregir vicios de refracción mientras tanto y control de diabetes; evitar corticoides prolongados.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 171

Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma crónico
B) Catarata
C) Degeneración macular relacionada con la edad
D) Vicio de refracción
E) Atrofia del nervio óptico

Respuesta B. Baja visual progresiva, con disminución de la sensibilidad al contraste y alteración del reflejo rojo pupilar: catarata. El glaucoma no altera el reflejo rojo ni la agudeza visual central hasta el final; el vicio de refracción no afecta el rojo pupilar.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 33

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. Tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y bastante menor en el derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía diabética
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Hemorragia vítrea

Respuesta C. Disminución progresiva de la agudeza visual con opacidad central en el rojo pupilar: catarata. La retinopatía diabética no da síntomas directos; el edema macular progresa en días, no de forma lenta; el glaucoma no afecta el rojo pupilar; la hemorragia vítrea es de aparición súbita.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 156

Paciente con agudeza visual 20/40 bilateral que no mejora con agujero estenopeico. La refracción no muestra cambios. **¿Cuál es la causa más probable de esta alteración visual?**

A) Opacidad de medios, como una catarata
B) Error refractivo no corregido
C) Ambliopía
D) Glaucoma
E) Degeneración macular

Respuesta A. El agujero estenopeico mejora la visión solo cuando la causa es un error refractivo. Si no mejora y la refracción es normal, la causa es una opacidad de medios, como la catarata, o una patología retinal o neural; en un adulto mayor, lo más probable es catarata.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Lactante de 7 meses cuya madre nota que al iluminar sus ojos con linterna, el ojo derecho refleja luz blanca (leucocoria) en vez del habitual reflejo rojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Descartar toxoplasmosis ocular: solicitar serología
B) Catarata congénita: derivar urgente a oftalmología
C) Retinoblastoma: derivar urgente a oftalmología
D) Retinopatía del prematuro: si no fue prematuro, tranquilizar
E) Glaucoma congénito: iniciar colirio

Respuesta B. Leucocoria (reflejo pupilar blanco) en lactante: principal diagnóstico a descartar es CATARATA CONGÉNITA y retinoblastoma. A los 7 meses sin antecedente de prematuridad, catarata congénita es lo más frecuente. Derivación urgente a oftalmología para tratamiento precoz (cirugía antes de los 10 semanas para evitar ambliopía).

6.02.1.004 Chalazion

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Chalazión: granuloma lipídico por obstrucción de una glándula de Meibomio, sin infección activa; nódulo firme, redondeado, indoloro, en el espesor del párpado, con piel móvil, de semanas de evolución (a menudo tras un orzuelo mal resuelto).
- Específico: diagnóstico clínico; evertir el párpado para ver el lado conjuntival. Sospechar carcinoma sebáceo o basocelular si es recidivante en el mismo sitio, en adulto mayor, con pérdida de pestañas o ulceración (biopsia).
- Tratamiento inicial: compresas tibias y masaje del párpado 3–4 veces al día por varias semanas; muchos resuelven espontáneamente.
- Si persiste más de 2 meses, es muy grande o comprime la córnea y produce astigmatismo: curetaje quirúrgico o infiltración de triamcinolona intralesional por oftalmología.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si persiste, recidiva o es atípico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 42 años consulta por la aparición de un nódulo firme en el párpado superior derecho de 6 semanas de evolución. Refiere que hace dos meses tuvo un cuadro inflamatorio doloroso que se resolvió solo, quedando esta lesión que no le duele en absoluto. Al examen se palpa un nódulo subcutáneo redondeado de 5 milímetros en el espesor del tarso superior, no adherido a la piel y completamente indoloro a la palpación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Orzuelo interno agudo
B) Chalazión
C) Carcinoma sebáceo de párpado
D) Dacriocistitis crónica
E) Quiste de inclusión epidérmica

Respuesta B. Nódulo firme, bien delimitado, indoloro y de varias semanas de duración, que sucede a un episodio agudo previo mal resuelto, es la presentación clásica del chalazión: un granuloma por retención lipídica tras la obstrucción de una glándula de Meibomio. El orzuelo agudo duele; el carcinoma sebáceo se sospecha solo si el chalazión recidiva en un anciano con pérdida de pestañas.

6.02.1.005 Conjuntivitis bacteriana aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis bacteriana aguda (S. aureus, neumococo, Haemophilus): secreción mucopurulenta espesa y abundante que pega los párpados y pestañas al despertar; inyección conjuntival difusa sin dolor profundo ni baja de agudeza visual.
- Diagnóstico clínico; no requiere cultivo de rutina. Descartar signos de alarma (baja de visión, dolor profundo, pupila alterada, córnea opaca o fluoresceína positiva, hipopión/hipema) que obligan a derivar.
- Tratamiento completo: aseo de secreciones con suero fisiológico y colirio de cloranfenicol 0,5 % o ciprofloxacino cada 4 horas por 7 días; ungüento nocturno si se desea. Evitar corticoides y parches oclusivos.
- Si no mejora a las 48–72 horas, derivar a oftalmología. Si hay quemosis severa, edema palpebral progresivo o fiebre, sospechar celulitis orbitaria. Forma hiperaguda (secreción en chorro, quemosis severa; N. gonorrhoeae, recién nacido de 2–5 días o adulto joven): urgencia con ceftriaxona sistémica (1 g IM/EV adulto; 25–50 mg/kg RN), lavados continuos y hospitalización.
- Seguimiento completo: control a las 48–72 horas, higiene de manos y no compartir toallas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 44

Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Alergia al cloranfenicol
B) Celulitis orbitaria
C) Obstrucción lacrimal
D) Chalazión
E) Absceso tarsal

Respuesta B. Una conjuntivitis bacteriana que, en vez de mejorar con el colirio, progresa con más edema palpebral y quemosis, dejó de ser una conjuntivitis simple: son signos de que la infección pasó al tejido orbitario, una celulitis orbitaria. La alergia al cloranfenicol es infrecuente y no explica la quemosis.

6.02.1.006 Conjuntivitis bacteriana crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis bacteriana crónica (>4 semanas): ojo rojo bilateral con ardor, arenilla, epífora y secreción mucosa que a veces se vuelve purulenta; suele asociarse a blefaritis estafilocócica o rosácea ocular, ojo seco o dacriocistitis crónica.

- Sospecha: curso prolongado o recidivante, pestañas con costras y bordes palpebrales eritematosos; buscar rosácea, dermatitis seborreica y uso de lentes de contacto. Chlamydia trachomatis (tracoma/conjuntivitis de inclusión) y Moraxella son causas específicas.
- Tratamiento inicial: higiene palpebral diaria (compresas tibias, shampoo suave o suero), lágrimas artificiales y antibiótico tópico (ungüento de eritromicina o cloranfenicol) 2–3 semanas; derivar con cultivo si no responde.
- Banderas rojas: baja de visión, dolor, fotofobia o córnea alterada indican compromiso corneal: derivar.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para estudio (cultivo, descartar Chlamydia y causa de base) si es persistente o refractaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 75

Paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epífora y secreción mucosa que a veces se vuelve purulenta. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma agudo
B) Blefaritis
C) Uveítis
D) Dacriocistitis
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta E. Ojo rojo superficial bilateral de más de 4 semanas, con secreción mucopurulenta intermitente, ardor y epífora, es una conjuntivitis bacteriana crónica, habitualmente asociada a blefaritis estafilocócica o rosácea. Se trata con higiene palpebral y antibiótico tópico, y se toma cultivo si no responde. El glaucoma agudo y la uveítis son ojos rojos profundos, sin secreción.

6.02.1.007 Conjuntivitis no infecciosa

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis alérgica (hipersensibilidad tipo I; polen, ácaros, pelo de animales): prurito intenso y bilateral como signo cardinal, lagrimeo, secreción mucosa filante, quemosis, edema palpebral y papilas en empedrado en la conjuntiva tarsal; sin adenopatía preauricular; asociada a rinitis y atopia, estacional.
- Formas graves: queratoconjuntivitis vernal (niños varones, papilas gigantes, puntos de Trantas, riesgo corneal) y atópica (adultos con dermatitis atópica).
- Tratamiento completo en APS: evitar alérgeno, compresas frías, lágrimas artificiales sin preservantes y antihistamínico tópico de acción dual (olopatadina cada 12 horas, ketotifeno); antihistamínico oral si hay rinitis.
- Corticoides tópicos solo bajo control de oftalmología (riesgo de glaucoma, catarata y queratitis herpética); evitar colirios con vasoconstrictor crónico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología los casos graves (vernal, atópica), refractarios o con compromiso corneal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años, con rinitis alérgica, consulta en primavera por ojo rojo bilateral de 1 semana, con prurito intenso, lagrimeo y secreción mucosa filante. Al examen hay hiperemia conjuntival leve, quemosis y papilas en la conjuntiva tarsal, con agudeza visual normal y sin adenopatía preauricular. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Colirio de cloranfenicol cada 6 horas
B) Colirio antihistamínico estabilizador de mastocitos, como olopatadina, y compresas frías
C) Colirio de corticoide de alta potencia por 1 mes
D) Colirio de aciclovir
E) Oclusión ocular por 48 horas

Respuesta B. Prurito intenso, bilateral, estacional, con secreción mucosa y antecedente atópico es una conjuntivitis alérgica. Se trata con evitar el alérgeno, compresas frías, lágrimas artificiales y antihistamínicos tópicos de acción dual, como olopatadina. Los corticoides tópicos se reservan al especialista por el riesgo de glaucoma, catarata y queratitis herpética.

6.02.1.008 Conjuntivitis viral no complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis viral (adenovirus): secreción acuosa o serosa, sensación de arenilla, hiperemia con folículos en la conjuntiva tarsal inferior, adenopatía preauricular dolorosa (dato que confirma); empieza en un ojo y pasa al otro en 2–3 días; a veces fiebre y faringitis (fiebre faringoconjuntival).
- Muy contagiosa por contacto mano–ojo; autolimitada en 1–2 semanas. Complicación: queratitis puntata con fotofobia y visión borrosa (derivar).
- Tratamiento inicial: solo soporte: compresas frías, lágrimas artificiales sin preservantes, lavado de manos frecuente y no compartir toallas; reposo laboral o escolar por 7–10 días. No antibióticos ni corticoides.
- Sospecha de herpes (vesículas palpebrales, dendrita con fluoresceína) o signos de alarma (baja de visión, dolor profundo, fotofobia intensa, secreción purulenta en chorro): derivar de urgencia.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si hay compromiso corneal o persiste más de 2–3 semanas.

Sin pregunta

6.02.1.009 Dacriocistitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dacriocistitis aguda: infección del saco lagrimal (S. aureus, neumococo), casi siempre sobre obstrucción crónica del conducto nasolagrimal; masa roja, caliente, tensa y dolorosa en el canto interno (región inferomedial) con epífora.
- Específico: al comprimir suavemente el saco refluye material mucopurulento por el punto lagrimal; puede haber fiebre. Complicaciones: absceso, fístula y celulitis orbitaria (edema palpebral, dolor al mover el ojo, proptosis).
- Tratamiento inicial: antibiótico oral con cobertura para estafilococo (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo), calor local y analgesia; hospitalizar con antibiótico EV si hay signos de celulitis orbitaria, fiebre alta o niños pequeños.
- Contraindicación absoluta: no sondar ni irrigar la vía lagrimal en fase aguda (riesgo de diseminar a celulitis orbitaria); no usar solo colirios.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; una vez resuelto el cuadro agudo, la obstrucción se trata con dacriocistorrinostomía (cirugía definitiva).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 106

Una paciente de 60 años está en espera de cirugía por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epífora. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar antibióticos orales
B) Indicar masajes y compresiones locales
C) Indicar corticoides tópicos
D) Indicar antibióticos en colirios
E) Resolver quirúrgicamente

Respuesta A. Paciente con obstrucción nasolagrimal crónica conocida que ahora presenta aumento de volumen, dolor, eritema y epífora en la región medial del ojo: es una dacriocistitis aguda sobre esa obstrucción de base. El tratamiento de primera línea es antibiótico oral, dejando el sondaje o la cirugía definitiva para cuando el cuadro agudo se resuelva.

6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.14 Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

QUÉ HAY QUE SABER

- Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): primera causa de ceguera central en mayores de 60–65 años; factores: edad, tabaquismo (principal modificable), antecedente familiar y raza blanca. Lesión elemental:

drusas (depósitos lipídicos entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch).

- Seca o atrófica (85–90 %): progresión lenta en años, drusas y atrofia geográfica. Húmeda o exudativa (10–15 %, causa ~90 % de la ceguera severa): membrana neovascular coroidea por VEGF, con hemorragia subretiniana y pérdida rápida en días o semanas.
- Sospecha: metamorfopsia (líneas rectas onduladas, el síntoma más precoz), escotoma central que dificulta leer y reconocer rostros, con campo periférico siempre conservado (nunca produce ceguera total). Pesquisa en el box con rejilla de Amsler y fondo de ojo (agujero estenopeico no mejora).
- Tratamiento inicial: forma húmeda es urgencia retinológica: derivar de inmediato para inyecciones intravítreas anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept) mensual o bimestral; forma seca: suspender tabaco, dieta con vegetales de hoja verde y suplemento AREDS-2 (vitaminas C y E, zinc, cobre, luteína y zeaxantina), que frena pero no revierte la atrofia.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; enseñar autocontrol con rejilla de Amsler y consultar de inmediato ante cualquier distorsión nueva.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 105

Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y fumador de 30 paquetes-año, consulta por dificultades para leer, que ha empeorado lentamente. Además notó hace poco una metamorfopsia en el ojo izquierdo. Tiene agudeza visual de 0,8 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo, y al examen ocular se aprecia leve disminución del rojo pupilar bilateral, con reflejos fotomotores normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Glaucoma de ángulo abierto
C) Desprendimiento de retina
D) Glaucoma de ángulo estrecho
E) Retinopatía diabética

Respuesta A. La metamorfopsia, la edad avanzada y la dificultad progresiva y lenta para leer son el cuadro característico de la degeneración macular asociada a la edad. El fumador de larga data tiene además el principal factor de riesgo modificable. El glaucoma no da metamorfopsia y afecta primero el campo visual periférico, no la lectura.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 171

Un paciente de 72 años consulta por dificultades en la lectura, que han empeorado en el último mes, a pesar de que realizó un cambio de lentes hace 6 meses. No presenta otros síntomas, tiene agudeza visual 20/80 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo, y refiere que ve algunos objetos deformados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Glaucoma crónico
C) Cataratas
D) Desprendimiento de retina
E) Edema macular

Respuesta A. La deformación de los objetos, es decir la metamorfopsia, junto con la dificultad progresiva para leer que no mejora con un cambio de lentes reciente, orientan a degeneración macular asociada a la edad. Las cataratas dan visión borrosa difusa, sin distorsión de las formas; el glaucoma no altera la lectura fina hasta etapas muy tardías.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación: Foto 14 (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733276.html). El diagnóstico más probable es:

A) Desprendimiento de retina
B) Retinopatía hipertensiva
C) Trombosis de la vena central de la retina
D) Catarata
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta E. Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar

Paciente hipertenso con dificultad para la lectura y visión deformada de objetos pese a lentes recientes. ¿Diagnóstico más probable?

A) Retinopatía hipertensiva
B) Oclusión de vena central de la retina
C) Neuropatía óptica isquémica anterior
D) Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE)
E) Catarata nuclear

Respuesta D. Diagnóstico: Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) (opción D). Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 77 años de edad consulta porque, desde hace un año y medio, ha presentado dificultades para la lectura, a pesar de haber cambiado de lentes hace 6 meses. Además, en el último tiempo, nota que ha empeorado sus dificultades para ver con el ojo derecho, con deformación de las imágenes de dicho ojo. Al examen físico, la inspección ocular no tiene alteraciones, los reflejos fotomotor y de acomodación son normales, el rojo pupilar está presenta y la oculomotilidad está conservada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma de ángulo abierto
B) Catarata
C) Desprendimiento de retina
D) Degeneración macular relacionada con la edad
E) Neuritis óptica

Respuesta A. Diagnóstico: Glaucoma de ángulo abierto (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.02.1.011 Estrabismo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Estrabismo: desviación de los ejes visuales (endotropia, convergente, la más frecuente; exotropia, divergente) por alteración muscular, refractiva o neurológica; en el lactante, estrabismo intermitente y fluctuante es fisiológico hasta los 4–6 meses.
- Sospecha: reflejo corneal asimétrico en la prueba de Hirschberg, desviación al cover test, fotos con ojo desviado, inclinación de la cabeza; cualquier estrabismo constante o que persista después de los 6 meses se deriva. Descartar pseudoestrabismo por epicanto.
- Riesgo clave: ambliopía (supresión cortical del ojo desviado) cuya ventana de plasticidad se cierra a los 7–8 años; leucocoria o estrabismo súbito obligan a descartar retinoblastoma, catarata o lesión neurológica (parálisis de IV/VI par).
- Tratamiento inicial: derivar sin esperar (GES estrabismo en menores de 9 años); corrección óptica de vicios de refracción y parche sobre el ojo sano (no el ambliope) para forzar el uso del ojo flojo; cirugía correctora de músculos extraoculares en el especialista.
- Seguimiento: derivar a oftalmología pediátrica; control de agudeza visual hasta los 8–9 años.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 38

Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos, y movilidad ocular sin alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar fondo de ojo
B) Derivar a oftalmólogo pediátrico
C) Indicar parches oculares intermitentes
D) Solicitar tomografía computada de órbitas
E) Mantener el control habitual del niño sano

Respuesta E. En los primeros meses de vida, un estrabismo intermitente, fluctuante y con reflejo rojo y motilidad normales suele ser fisiológico, porque la fijación binocular aún no ha madurado. No exige derivación ni exámenes de urgencia; sí lo haría si fuera fijo, constante, o si alterara el reflejo rojo.

6.02.1.012 Glaucoma congénito

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma congénito (primario): malformación del ángulo con PIO elevada en lactantes; la presión distiende el globo aún elástico. Más frecuente en varones, bilateral en ~70 %.
- Sospecha: tríada epífora, fotofobia y blefarospasmo, más córnea opaca (edema) y aumento del diámetro corneal (buftalmo, ojos «grandes y hermosos»); estrías de Haab. Diferenciar de obstrucción lagrimal (epífora con córnea normal), megalocórnea y distrofias corneales.
- Manejo inicial: urgencia de derivación, no iniciar colirios ni parches; el tratamiento es quirúrgico (goniotomía o trabeculotomía) y precoz; los fármacos hipotensores son solo puente.
- Complicaciones si se retrasa: ceguera por daño del nervio óptico, ambliopía y opacidad corneal permanente.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología pediátrica; control de por vida de PIO, campo visual y refracción.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 31

Lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociada a epífora y aumento del diámetro corneal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinoblastoma
B) Macrocórnea
C) Glaucoma congénito
D) Atresia lagrimal
E) Catarata congénita

Respuesta C. Epífora, fotofobia, blefaroespasmo, córnea opaca (edema) y aumento del diámetro corneal (buftalmo) en un lactante son glaucoma congénito: la presión intraocular elevada distiende el globo ocular aún elástico. Es una urgencia de derivación porque su tratamiento es quirúrgico. La atresia lagrimal da epífora con córnea normal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se realiza medición del diámetro corneal, que resulta 14 mm (VN: 10 a 12 mm) y prueba de fluoresceína, con aclaramiento de 5 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Glaucoma congénito
B) Atresia de la vía lagrimal
C) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
D) Ambliopía
E) Retinopatía del prematuro

Respuesta A. Glaucoma Congénito: La epífora, megalocórnea y buftalmos sugieren glaucoma congénito. La prueba de fluoresceína con aclaramiento lento es compatible con dacriocistitis congénita y glaucoma congénito. El valor normal del aclaramiento de fluoresceína es menor a 5 minutos.

6.02.1.013 Glaucoma crónico

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma crónico de ángulo abierto: neuropatía óptica progresiva por mala función de la malla trabecular; es la primera causa de ceguera irreversible. Silencioso: sin dolor, sin ojo rojo y con agudeza visual 20/20 hasta etapas terminales.
- Factores de riesgo: PIO >21 mmHg (aunque hasta 40 % es de presión normal), edad, familiar de primer grado (predictor más fuerte), raza negra, miopía alta, diabetes. Daño de fibras periféricas: escotoma de Bjerrum, escalón nasal y luego visión en túnel.
- Sospecha en APS con fondo de ojo: excavación papilar >0,5 o asimetría entre ambos ojos >0,2, muescas del anillo neurorretiniano y vasos nasalizados. Una agudeza visual normal no descarta el diagnóstico.
- Confirmación por oftalmología: tonometría, gonioscopía (ángulo abierto), campimetría computarizada y OCT de fibras nerviosas. Tratamiento de por vida: colirio de análogo de prostaglandina (latanoprost, una gota nocturna; oscurece el iris y alarga pestañas), betabloqueador (timolol; contraindicado en asma y bloqueo AV), trabeculoplastía o trabeculectomía si progresa. GES glaucoma.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; pesquisar activamente a familiares de primer grado y a mayores de 40 años con factores de riesgo.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 147

Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0,7 en el ojo derecho, y en la gonioscopía se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía diabética
B) Neuritis óptica
C) Glaucoma crónico
D) Coriorretinitis
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta C. Presión intraocular elevada, excavación papilar aumentada, con gonioscopía que confirma el ángulo abierto: glaucoma crónico de ángulo abierto, el diagnóstico que arma exactamente esta tríada.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 166

Un paciente de 60 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, consulta por disminución progresiva de la calidad de la visión. A su examen físico, la exploración ocular es normal, con rojo pupilar normal bilateral. La agudeza visual es 20/25 en ambos ojos. La campimetría muestra defectos en los dos cuadrantes superiores del campo visual izquierdo y en los dos cuadrantes mediales del campo visual derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Tumor del lóbulo occipital
C) Catarata
D) Glaucoma crónico
E) Neuropatía óptica isquémica

Respuesta D. Agudeza visual conservada, con defectos de campo visual periféricos y asimétricos entre ambos ojos, y examen ocular externo normal: patrón clásico de glaucoma crónico. La degeneración macular y la catarata afectan la agudeza visual; un tumor occipital daría una hemianopsia homónima, no este patrón bimedial.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años se realiza una tonomotría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteracios. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Neuropatía óptica
C) Glaucoma crónico
D) Catarata
E) Desprendimiento de retina

Respuesta C. Es un glaucoma crónico clásico, tanto por la PIO mayor a 20, como por la excavación papilar mayor a 0,3.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 67 años, con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexato y prednisona, consulta por dificultades para ver. Tiene historia de cirugía de cataratas hace dos años. Al examen oftalmológico se constata agudeza vidual 20/25 a derecha y 20/30 a izquierda y, en la campimetría visual, se observa afectación de la zona medial del campo visual derecho y de la zona superior del campo visual izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Desprendimiento de retina
B) Lesión del quiasma óptico
C) Glaucoma crónico
D) Neuritis óptica
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta C. Tiene agudeza visual normal, pero afectación del campo visual, lo que sugiere un glaucoma crónico. Se asocia al uso de corticoides y alos factores de riesgo cardiovascular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con glaucoma crónico, con ojo izquierdo con visión en túnel y ojo derecho con el signo de humo de chimenea, al evaluar el ojo con glaucoma crónico, ¿qué hallazgo tendría?:

A) Midriasis arreflectica
B) Reflejo ?/
C) Miosis
D) Defecto pupilar aferente (esta porque la principal complicación del glaucoma crónico es el daño del nervio óptico que se vería con un DPA)
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Midriasis arreflectica). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Reflejo ?/, Miosis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con vision tubular, y un signo de humo de chimenea en el ojo _. Visión derecho digital? e izq 20/20. Reflejo fotomotor alterno/RFM alterado creo . ¿Cuál es el diagnóstico? ALGUIEN QUE MEJORE ESTA PREGUNTA A LAS ALTERNATIVAS: me parece que esta tenía glaucoma de ángulo abierto en las alternativas?

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.02.1.014 Hifema

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Hifema (hipema) traumático: sangre en la cámara anterior por rotura de vasos del iris o cuerpo ciliar tras un trauma contuso (puñetazo, pelota); se ve un nivel de sangre en el sector inferior de la cámara anterior, con baja visual y dolor. Es un trauma cerrado, pero descartar globo abierto.
- Específico: graduar por la altura del nivel (<1/3, 1/3–1/2, >1/2, total). Buscar signos de globo abierto (pupila en gota, Seidel positivo, hipotonía) antes de manipular; investigar anemia falciforme y anticoagulantes.
- Tratamiento inicial: reposo con cabecera elevada a 30–45° para que los eritrocitos decanten, protector ocular rígido sin compresión, analgesia con paracetamol y evitar aspirina y AINE (alteran la hemostasia); antiemético si hay náuseas.
- Complicaciones: resangrado a las 48–72 horas (suele ser mayor que el inicial), glaucoma secundario agudo y tinción hemática de la córnea; el drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para vigilancia diaria de la presión intraocular y tratamiento hipotensor si corresponde.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2, y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. **¿Cuál de las siguientes conductas representa una acción estrictamente contraindicada en este paciente?**

A) Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva
B) Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa
C) Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular
D) Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología
E) Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

Respuesta C. Ante signos inequívocos de globo ocular abierto (pupila en gota con herniación de tejido uveal y atalamia), medir la presión intraocular está estrictamente contraindicado: el contacto del tonómetro presiona el ojo y puede expulsar el contenido intraocular. La protección con concha rígida, la analgesia y antieméticos EV, y el ayuno son conductas mandatorias.

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años recibe un pelotazo de fútbol en el ojo izquierdo hace 3 horas. Refiere visión borrosa. Al examen: agudeza visual 20/50, nivel de sangre de 2 mm en la cámara anterior inferior, córnea transparente, sin laceraciones ni deformación pupilar. No tiene antecedentes de anemia de células falciformes ni usa anticoagulantes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reposo con cabecera elevada a 30-45 grados, protector ocular rígido, evitar AINE y derivar a oftalmología para control de presión intraocular
B) Alta con ibuprofeno para el dolor y control en una semana
C) Masaje ocular para redistribuir la sangre y parche compresivo
D) Drenaje inmediato de la cámara anterior en el servicio de urgencia
E) Colirio de pilocarpina cada 6 horas y control en 48 horas

Respuesta A. El hifema traumático se maneja con reposo semisentado, protector rígido (sin compresión), evitar AINE y aspirina por riesgo de resangrado y derivación a oftalmología, que vigila la presión intraocular y la tinción hemática corneal. El drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados.

6.02.1.015 Leucoma corneal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Leucoma corneal: cicatriz corneal blanca, densa y bien delimitada, secuela de úlceras (bacterianas, herpéticas), traumas, quemaduras químicas o queratitis; ojo blanco, sin dolor, que no tiñe con fluoresceína (a diferencia de la úlcera activa).
- Específico: antecedente de úlcera o trauma corneal, opacidad central o paracentral y baja de agudeza visual; en niños puede causar ambliopía por privación visual.
- Tratamiento inicial en APS: confirmar con fluoresceína que no hay úlcera activa, lubricación y protección ocular; no usar corticoides ni antibióticos sin indicación; evitar frotar el ojo.
- Si es central y compromete la visión: queratoplastía (trasplante de córnea) o rehabilitación óptica por oftalmología; en lactantes derivar urgente por riesgo de ambliopía.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para evaluar trasplante, corrección óptica y control de ambliopía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años con antecedente de úlcera corneal bacteriana en el ojo derecho hace 1 año, tratada. Consulta por visión borrosa persistente de ese ojo. Al examen se observa una opacidad blanca, densa y bien delimitada en el centro de la córnea, que no tiñe con fluoresceína. El ojo está blanco y sin dolor. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Úlcera corneal activa; antibiótico tópico
B) Catarata; facoemulsificación
C) Leucoma corneal central; derivar a oftalmología para evaluar queratoplastía (trasplante de córnea)
D) Pterigion; exéresis
E) Queratitis herpética; aciclovir

Respuesta C. El leucoma es una cicatriz corneal blanca y densa, secuela de úlceras, traumas o queratitis. Si es central, disminuye la agudeza visual y en niños puede causar ambliopía. Se diferencia de la úlcera activa porque no tiñe con fluoresceína y el ojo está tranquilo. El tratamiento de un leucoma central que compromete la visión es la queratoplastía.

6.02.1.016 Neuritis óptica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuritis óptica: inflamación desmielinizante autoinmune del nervio óptico; mujer joven (20–40 años) con baja visual monocular subaguda en horas a 2–3 días, dolor periocular que aumenta al mover el ojo (>90 %) y discromatopsia (rojo descolorido).
- Sospecha: defecto pupilar aferente relativo (pupila de Marcus Gunn, el signo objetivo más sensible) y fondo de ojo normal en ~65 % (neuritis retrobulbar); en ~35 % papilitis con edema leve de papila. No descartarla por tener fondo de ojo normal.
- Asociación con esclerosis múltiple (~50 % a futuro; GES de sospecha de esclerosis múltiple): solicitar resonancia de encéfalo y órbitas con gadolinio, que predice el riesgo.
- Tratamiento inicial: derivar con pulsos de metilprednisolona EV 1 g/día por 3–5 días y luego prednisona oral decreciente; prednisona oral sola a dosis bajas está contraindicada (estudio ONTT: duplica las recurrencias).
- Seguimiento: derivar a oftalmología/neurología para estudio de esclerosis múltiple; diferenciar de papiledema (bilateral, AV conservada, sin dolor ocular), de neuropatía isquémica (>50 años, indolora) y de compresión tumoral.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 5

Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probale?**

A) Desprendimiento de retina
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Trombosis de arteria central de la retina
D) Neuritis óptica
E) Absceso orbitario

Respuesta D. Baja visual en días, dolor retroocular que aumenta con los movimientos oculares y defecto pupilar aferente, en una paciente con esclerosis múltiple: neuritis óptica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 82

Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discromatopsia
B) Retinitis pigmentosa
C) Coriorretinitis
D) Desprendimiento de retina
E) Neuritis óptica

Respuesta E. Dolor ocular y visión borrosa de días, con gran compromiso de la visión de colores aunque la agudeza visual esté casi normal, en una paciente con esclerosis múltiple: neuritis óptica. La discromatopsia es un signo, no el diagnóstico.

6.02.1.017 Neuropatía óptica isquémica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuropatía óptica isquémica anterior: infarto de la cabeza del nervio óptico; pérdida visual brusca e indolora, edema de papila (pálido en la arterítica) con hemorragias peripapilares en llama y defecto pupilar aferente.
- Arterítica (arteritis de células gigantes): >50 años, cefalea temporal de nuevo inicio, claudicación mandibular (el signo más específico), alodinia del cuero cabelludo, polimialgia reumática, VHS/PCR muy elevadas; ceguera irreversible y riesgo >50 % de afectar el otro ojo en 24–48 horas. No arterítica: factores vasculares (HTA, diabetes, apnea del sueño, papila pequeña «de riesgo»).
- Regla de oro: ante sospecha de arteritis temporal iniciar corticoides inmediatamente sin esperar la biopsia (metilprednisolona EV en pulsos si hay síntomas visuales; prednisona 1 mg/kg/día si no los hay); biopsia de arteria temporal de al menos 1,5–2 cm o ecografía Doppler (signo del halo).
- Tratamiento inicial: derivar de urgencia, pedir VHS, PCR y hemograma; tocilizumab como ahorrador de corticoides en recaídas; antiagregación según indicación y control de factores de riesgo vascular en la forma no arterítica.
- Seguimiento: derivar a oftalmología y reumatología; descenso lento de corticoides con profilaxis de osteoporosis.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM · Ahorrador de corticoides en Arteritis Temporal

En un paciente de 70 años con arteritis de células gigantes que ha presentado múltiples recaídas al intentar reducir la dosis de prednisona por debajo de 20 mg/día, desarrollando además fractura vertebral osteoporótica y diabetes inducida por corticoides. ¿Cuál es el fármaco biológico modificador de la enfermedad de primera línea con aprobación formal para actuar como ahorrador de corticoides en esta patología?

A) Infliximab (anti-TNF alfa)
B) Tocilizumab (antagonista del receptor de interleucina-6)
C) Rituximab (anti-CD20 de células B)
D) Anakinra (antagonista del receptor de interleucina-1)
E) Secukinumab (inhibidor de interleucina-17A)

Respuesta B. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el receptor de la interleucina-6 (IL-6R). El ensayo pivotal GiACTA demostró que la adición de Tocilizumab permite alcanzar y sostener la remisión libre de corticoides en más del 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes, reduciendo sustancialmente la dosis acumulada de glucocorticoides y sus severos efectos adversos osteoporóticos y metabólicos.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neuritis óptica
B) Degeneración macular relacionada con la edad
C) Accidente vascular encefálico occipital
D) Edema macular
E) Neuropatía óptica isquémica

Respuesta E. Tiene una amaurosis parcial súbita, lo que sugiere fuertemente una neuropatía óptica isquémica. Por ser la parte inferior del campo visual izquierdo lo afectado, probablemente la lesión se produjo en la parte superior del nervio óptico izquierdo. La neuritis óptica se instala en horas o días, la DMRE demora meses o años, el edema macular demora días y el accidente vascular occipital tiene una hemi

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y revascularización coronaria hace 3 años, consulta porque hace pocas horas notó que, de forma súbita, dejó de ver su pierna derecha con el ojo derecho. Al examen físico presenta inspección ocular normal, agudeza visual 20/30 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, pupilas isocóricas con defecto pupilar aferente relativo, y en la campimetría por confrontación se observa hemianopsia inferior del ojo derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Neuri2s óp2ca isquémica
B) Infarto del lóbulo occipital
C) Desprendimiento de re2na
D) Glaucoma
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta A. Tanto por el inicio súbito, con factores de riesgo cardiovascular, como por el defecto pupilar aferente relativo (DPAR), es una neuropatía óptica isquémica, con afectación de la zona superior del nervio óptico derecho (inerva la zona superior de la retina y corresponde a la zona inferior del campo visual). El DPAR se ve también en la neuritis óptica desmielinizante y en el desprendimiento de retin

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

A) Glaucoma agudo
B) Glaucoma crónico terminal
C) Neuritis óptica
D) Neuropatía óptica isquémica
E) Desprendimiento de retina

Respuesta D. Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

6.02.1.018 Obstrucción completa de la vía lacrimal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción de la vía lagrimal: lagrimeo continuo (epífora) por falla en el drenaje. Congénita (6–20 % de recién nacidos, membrana de Hasner imperforada): epífora y secreción desde las primeras semanas, ojo blanco, reflujo de material al comprimir el saco; en adultos por estenosis involutiva, traumas o infecciones.
- Específico: diagnóstico clínico (epífora crónica, reflujo por el punto lagrimal a la presión del saco, test de desaparición de fluoresceína alterado); diferenciar de glaucoma congénito (epífora con fotofobia, córnea grande y turbia), conjuntivitis y dacriocele.
- Tratamiento inicial en el lactante: masaje del saco lagrimal (maniobra de Crigler) 2–3 veces al día, aseo con suero fisiológico y antibiótico tópico solo si hay sobreinfección; >90 % se resuelve antes del año.

- Si persiste después de los 6–12 meses: sondaje de la vía lagrimal por oftalmología. En el adulto con obstrucción completa: dacriocistorrinostomía; no sondar durante dacriocistitis aguda.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; derivar antes si hay dacriocele, dacriocistitis, celulitis o sospecha de glaucoma congénito.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 60**
>
> Niño de 4 meses consulta por epífora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial (canto interno), con reflujo de secreción al comprimir el saco lagrimal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Glaucoma congénito
> **B)** Conjuntivitis bacteriana
> **C)** Atresia lagrimal congénita
> **D)** Queratitis por Chlamydia trachomatis
> **E)** Dacriocele
>
> Respuesta C. La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal (membrana de Hasner imperforada) da epífora y secreción con reflujo a la compresión del saco, en un ojo sin otras alteraciones. Se maneja con masaje del saco lagrimal (Crigler) y aseo; la mayoría se resuelve antes del año, y si persiste se indica sondaje. El dacriocele es una masa azulada presente al nacer.

6.02.1.019 Orzuelo no complicado

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Orzuelo (hordeolum): infección aguda de glándulas de Zeiss y Moll (externo, en la base de una pestaña) o de Meibomio (interno), casi siempre por S. aureus; nódulo eritematoso, caliente y muy doloroso, a veces con pústula.
- Específico: diagnóstico clínico; distinguir de chalazión (indoloro, crónico), dacriocistitis (canto interno) y celulitis preseptal (edema y eritema difuso del párpado, fiebre).
- Tratamiento completo: compresas tibias húmedas 3–4 veces al día para favorecer el drenaje espontáneo, higiene palpebral y ungüento oftálmico antibiótico (eritromicina o cloranfenicol).
- No puncionar ni exprimir de forma precoz; antibiótico oral solo si hay celulitis circundante. No usar corticoides.
- Seguimiento completo: resuelve en 5–7 días; derivar si no drena, evoluciona a chalazión persistente o hay celulitis preseptal/orbitaria.

Sin pregunta

6.02.1.020 Pterigion

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

QUÉ HAY QUE SABER

- Pterigion: pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva bulbar (habitualmente nasal) que invade la córnea; asociado a exposición UV, viento y polvo (pescadores, agricultores). Sensación de cuerpo extraño, ojo rojo recurrente; agudeza visual normal salvo que llegue al eje visual.
- Específico: se diagnostica por inspección; distinguir de pinguécula (engrosamiento amarillento conjuntival que no invade la córnea) y de tumores conjuntivales (aspecto leucoplásico, vascularización atípica).
- Tratamiento inicial: lágrimas artificiales, protección solar con lentes con filtro UV y sombrero; antiinflamatorio tópico solo en episodios inflamatorios (corticoide únicamente indicado por oftalmólogo).
- Cirugía (exéresis con autoinjerto conjuntival para disminuir recidiva) cuando amenaza el eje visual, induce astigmatismo, limita la motilidad o por estética.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para control periódico y cirugía si progresa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años, pescador, consulta por sensación de cuerpo extraño y enrojecimiento del ojo derecho. Al examen se observa un pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva bulbar nasal que invade 2 mm la córnea. La agudeza visual es normal. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Exéresis quirúrgica inmediata
B) Biopsia urgente
C) Corticoide tópico crónico
D) Antibiótico tópico
E) Lubricantes tópicos, protección solar con lentes con filtro UV y control; cirugía si progresa hacia el eje visual o produce astigmatismo

Respuesta E. El pterigion es una proliferación fibrovascular de la conjuntiva que invade la córnea, asociada a exposición UV, viento y polvo. Se maneja con lubricantes, antiinflamatorios en reagudizaciones y protección solar. La cirugía (con autoinjerto conjuntival para reducir recidiva) se indica si amenaza el eje visual, induce astigmatismo, limita la motilidad o por estética.

6.02.1.021 Queratitis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo · Tema 15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Queratitis: inflamación o infección de la córnea. Ojo rojo con inyección ciliar, dolor punzante, blefarospasmo, fotofobia y lagrimeo; la córnea se tiñe con fluoresceína bajo luz azul de cobalto (examen de cabecera).
- Herpética (VHS-1): úlcera dendrítica ramificada con botones terminales, hipoestesia corneal, recidiva con fiebre o estrés. Bacteriana: infiltrado blanco denso con defecto epitelial y a menudo hipopión, en usuarios de lentes de contacto blandos (Pseudomonas). Actínica: dolor bilateral horas después de exposición UV sin protección, cura en 24–48 horas.
- Tratamiento inicial: derivación prioritaria a oftalmología (el mismo día si es bacteriana); herpética: aciclovir ungüento oftálmico 3 % cinco veces al día por 10–14 días; bacteriana: retirar y guardar los lentes para cultivo, antibióticos reforzados (vancomicina + ceftazidima o moxifloxacino) y no ocluir con parche.
- Regla de oro: JAMÁS corticoides tópicos en una úlcera corneal sospechada o confirmada (transforman la dendrita en úlcera geográfica y pueden perforar); tampoco anestésico tópico repetido ni midriáticos. Ciclopléjico para el dolor por espasmo ciliar.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; control estrecho hasta cicatrización y rehabilitación visual si deja leucoma.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 156

Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen físico, presenta epífora y ojo rojo derecho de tipo central. Como antecedente, tiene astigmatismo y es usuaria de lentes de contacto. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A) Fondo de ojo
B) Tonometría ocular
C) TAC de órbitas
D) Tinción con fluoresceína
E) Gonioscopía

Respuesta D. Usuaria de lentes de contacto, con dolor ocular agudo, ojo rojo central y epífora: la sospecha es una queratitis o una erosión corneal. El examen que confirma la lesión epitelial de la córnea es la tinción con fluoresceína bajo luz azul de cobalto, no la tonometría ni la gonioscopía, que son propias del estudio del glaucoma.

Pregunta de práctica

Un paciente de 35 años consulta por dolor ocular derecho punzante, fotofobia intensa y lagrimeo de 2 días de evolución. Al teñir la córnea con una gota de fluoresceína y observar bajo luz azul de cobalto, se aprecia una lesión epitelial corneal superficial de aspecto arborescente y ramificado, con extremos bulbosos. **¿Cuál de los siguientes fármacos está formalmente contraindicado por el riesgo de inducir perforación corneal?**

A) Aciclovir ungüento oftálmico al 3 por ciento
B) Ganciclovir gel oftálmico al 0,15 por ciento
C) Dexametasona colirio oftálmico al 0,1 por ciento
D) Ciclopentolato colirio al 1 por ciento
E) Lágrimas artificiales de hialuronato de sodio

Respuesta C. La lesión descrita, arborescente y con botones terminales, es una úlcera dendrítica herpética. Los corticoides tópicos, como la dexametasona, están terminantemente contraindicados: inhiben la inmunidad local, favorecen la replicación viral y pueden transformar la dendrita en una úlcera geográfica con perforación corneal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con micofenolato y terapia biológica, consulta por dolor ocular, epífora y ojo rojo bilateral asociado a fotofobia. Refiere que los síntomas empeoran en la tarde, al término de su jornada laboral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quera22s
B) Uveí2s
C) Glaucoma agudo
D) Conjun2vi2s viral
E) Celuli2s orbitaria

Respuesta A. Una paciente con artritis reumatoide puede desarrollar síndrome de Sjögren secundario, que produce ojo seco y queratitis sicca. Los síntomas que empeoran en la tarde, tras una jornada de uso visual, son típicos de ojo seco. La uveítis suele dar dolor y fotofobia intensos sin ese patrón, y el glaucoma agudo y la celulitis orbitaria tienen otro cuadro clínico.

6.02.1.022 Retinopatía del prematuro

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía del prematuro (ROP): vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, favorecida por prematurez, bajo peso e hiperoxia; puede evolucionar a neovascularización, desprendimiento de retina y ceguera.
- Sospecha/pesquisa: todo prematuro <32 semanas o <1.500 g (y los mayores con oxígeno prolongado o inestabilidad) tiene garantía GES de tamizaje con fondo de ojo dilatado por oftalmólogo, desde alrededor de las 4 semanas de vida (o 31 semanas de edad posmenstrual); no esperar leucocoria, que indica retina ya desprendida.
- Manejo inicial: el neonatólogo coordina el tamizaje; mantener oxigenoterapia con saturación controlada y buen aporte nutricional; derivar a oftalmología para clasificar por zona, estadio y enfermedad «plus».
- Tratamiento por oftalmología según gravedad: láser de la retina avascular o antiangiogénicos intravítreos (bevacizumab/ranibizumab); cirugía en desprendimiento.
- Seguimiento: controles oftalmológicos seriados hasta la vascularización completa y luego anual por miopía, estrabismo y ambliopía; derivar de inmediato ante leucocoria o estrabismo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 29 semanas de gestación y 1.150 g de peso al nacer, que requirió oxigenoterapia prolongada. Se encuentra en la unidad de neonatología a las 4 semanas de vida. **Respecto de la retinopatía del prematuro, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) No requiere evaluación, porque está en oxígeno controlado
B) Evaluar al alta, a los 6 meses de edad
C) Evaluar solo si presenta leucocoria
D) Examen de fondo de ojo con pupila dilatada por oftalmólogo, según GES, en prematuros menores de 32 semanas o menores de 1.500 g
E) Indicar vitamina A como tratamiento

Respuesta D. La retinopatía del prematuro es una vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, favorecida por prematurez, bajo peso e hiperoxia. Es GES: se tamiza con fondo de ojo dilatado por oftalmólogo a todo prematuro menor de 1.500 g o de 32 semanas, desde las 4 semanas de vida, y se trata con láser o antiangiogénicos.

6.02.1.023 Retinopatía diabética

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES · Tema 15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía diabética: microangiopatía por hiperglicemia crónica (pérdida de pericitos, isquemia, VEGF); primera causa de ceguera irreversible en edad laboral. Es asintomática hasta etapas avanzadas, por eso se busca activamente.
- Sospecha por fondo de ojo (con pupila dilatada): no proliferativa = microaneurismas (lesión más precoz), hemorragias en punto y mancha, exudados duros y algodonosos, sin neovasos; severa por regla 4-2-1; proliferativa = presencia de neovasos en papila o retina, con riesgo de hemorragia vítrea y desprendimiento traccional.
- Edema macular diabético: engrosamiento de la fóvea, puede ocurrir en cualquier etapa y es la causa más frecuente de baja visual en el diabético; se confirma con OCT y se trata con anti-VEGF intravítreo.
- Tamizaje GES retinopatía diabética: DM2 con fondo de ojo al momento del diagnóstico y luego anual; DM1 desde los 5 años del debut, luego anual. Tratamiento inicial en APS: control metabólico y de presión arterial/lípidos, notificar GES y derivar; no recetar lentes mientras la glicemia esté inestable (cambios refractivos transitorios).
- Seguimiento por oftalmología: panfotocoagulación láser en proliferativa (prioritaria, GES plazo de 60 días), anti-VEGF en edema, vitrectomía si la hemorragia no se reabsorbe; controles anual (leve) hasta cada 1–3 meses (proliferativa).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra completamente asintomático desde el punto de vista visual. **¿Cuál es la indicación correcta respecto al tamizaje oftalmológico según las guías del MINSAL y la garantía GES número veintitrés?**

A) Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente
B) Esperar cinco años desde el diagnóstico para realizar el primer fondo de ojo
C) Solicitar fondo de ojo únicamente si la hemoglobina glicosilada supera el ocho por ciento
D) Realizar fondo de ojo solo cuando el paciente refiera disminución de la agudeza visual
E) Derivar a cirugía preventiva de cataratas bilateral de inmediato

Respuesta A. En la diabetes tipo 2, la enfermedad suele tener un curso subclínico de varios años antes del diagnóstico formal, así que hasta un 20 por ciento de los pacientes ya tiene algún grado de retinopatía al debut. La norma MINSAL y el GES 23 exigen fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico, y luego una vez al año de por vida; en la DM1, el tamizaje se inicia a los 5 años del debut.

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años con DM2 de 10 años de evolución, HbA1c 9 %, asintomático. En su control anual, la retinografía en APS muestra microaneurismas, exudados duros y vasos anómalos y frágiles sobre el disco óptico. Agudeza visual conservada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Optimizar el control metabólico y repetir la retinografía en 1 año
B) Derivación prioritaria a oftalmología para panfotocoagulación con láser de argón
C) Iniciar inyecciones intravítreas de anti-VEGF como único tratamiento
D) Vitrectomía de urgencia
E) Controlar solo si aparece pérdida de visión

Respuesta B. Neovasos en el disco óptico definen una retinopatía proliferativa, aunque el paciente vea bien. El tratamiento de elección es la panfotocoagulación con láser de argón (GES), que reduce el VEGF y hace regresar los neovasos. El anti-VEGF es la primera línea del edema macular central; la vitrectomía se plantea ante la hemorragia vítrea o el desprendimiento traccional.

6.02.1.024 Síndrome de ojo seco

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis seca): sensación constante de arenilla o cuerpo extraño, ardor, fotofobia, hiperemia, fatiga visual al leer o usar pantallas y lagrimeo reflejo; por déficit acuoso (Sjögren, edad, fármacos) o evaporativo (disfunción de glándulas de Meibomio, blefaritis, rosácea, uso prolongado de pantallas).
- Sospecha de Sjögren: mujer de mediana edad con xeroftalmía y xerostomía, caries cervicales, aumento de parótidas y anti-Ro/La positivos; Schirmer <5 mm en 5 minutos. El Sjögren aumenta ~40 veces el riesgo de linfoma no Hodgkin B (MALT): una parótida dura o asimétrica obliga a biopsia.
- Tratamiento inicial en APS: lágrimas artificiales sin conservantes varias veces al día, ungüento lubricante nocturno, higiene palpebral con compresas tibias, parpadeo frecuente y pausas con pantallas, humedad ambiental, y suspender fármacos que resecan (antihistamínicos, anticolinérgicos).
- Banderas rojas: dolor intenso, fotofobia, disminución de la visión o tinción corneal con fluoresceína (úlcera o queratitis): derivar. Evitar colirios con vasoconstrictor y corticoides sin control oftalmológico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología (ciclosporina tópica, tapones lagrimales) y a reumatología si se sospecha Sjögren o enfermedad autoinmune.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 114

Paciente de 40 años con ojo rojo, sensación de arenilla, lagrimeo y fotofobia desde hace 3 meses. Usa lentes de contacto hace años. Antecedente de artritis reumatoide. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis sicca)
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Úlcera corneal por Acanthamoeba
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

Respuesta A. Los síntomas crónicos de sensación de cuerpo extraño o arenilla, lagrimeo reflejo y fotofobia en un paciente con artritis reumatoide corresponden a queratoconjuntivitis seca por síndrome de Sjögren secundario, la manifestación oftalmológica más frecuente de la enfermedad.

6.02.1.025 Tumores de conjuntiva

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores de conjuntiva: pueden ser benignos (nevo conjuntival, papiloma, quiste de inclusión, pinguécula) o malignos (neoplasia escamosa de la superficie ocular/carcinoma espinocelular, melanoma, linfoma conjuntival «salmón»).
- Específico: lesión en conjuntiva bulbar o limbo, a veces con vasos nutricios dilatados; leucoplasia o placa gelatinosa limbar sugieren neoplasia escamosa (expuestos a UV, VIH, VPH); lesión pigmentada que crece,

cambia de color o sangra sugiere melanoma; masa rosada en fornix, linfoma.
- Diferenciar de pterigion (fibrovascular triangular que invade la córnea), pinguécula y quistes; vigilar cualquier lesión que crece, se vasculariza o ulcera.
- Tratamiento inicial: no manipular ni cauterizar; fotografiar y derivar con prioridad a oftalmología para biopsia excisional con técnica «sin tocar» y estudio histológico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oncología ocular; tratamiento quirúrgico con crioterapia y quimioterapia tópica (mitomicina o 5-FU); control a largo plazo por recidiva.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 65 años, agricultor, con una lesión en la conjuntiva bulbar temporal del ojo izquierdo, en el limbo, de crecimiento progresivo en 6 meses. Es gelatinosa, blanquecina, con vasos nutricios prominentes y áreas de leucoplaquia. Tiene antecedente de VIH. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Lubricantes y control anual, porque es un pterigion
> **B)** Antibiótico tópico por 7 días
> **C)** Derivar a oftalmología para biopsia excisional por sospecha de neoplasia escamosa de la superficie ocular
> **D)** Corticoide tópico
> **E)** Crioterapia en atención primaria
> Respuesta C. Una lesión conjuntival limbar gelatinosa o leucoplásica, con vasos nutricios y crecimiento progresivo, en un adulto mayor con exposición solar o inmunosupresión (VIH), sugiere neoplasia escamosa de la superficie ocular (displasia a carcinoma). Se deriva para biopsia excisional. A diferencia del pterigion, no es triangular nasal ni típicamente horizontal, y crece rápido.

6.02.1.026 Tumores de la vía óptica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Glioma de la vía óptica (astrocitoma pilocítico): tumor de la vía óptica más frecuente en la infancia; fuerte asociación con neurofibromatosis tipo 1 (manchas café con leche, efélides axilares, neurofibromas).
- Sospecha: baja de agudeza visual progresiva, discromatopsia, defecto pupilar aferente, palidez de la papila (atrofia óptica), estrabismo, nistagmo o proptosis unilateral progresiva e indolora en un niño; puede comprometer el quiasma (defectos campimétricos, pubertad precoz, síndrome diencefálico).
- Otros: meningioma de la vaina del nervio óptico (adulto), adenoma hipofisario y craneofaringioma con hemianopsia bitemporal.
- Estudio inicial: resonancia magnética de cerebro y órbitas con gadolinio, campo visual y evaluación oftalmológica; en NF1 control oftalmológico anual en la infancia.
- Tratamiento inicial: derivar a oftalmología y neuro-oncología; observación en casos estables, quimioterapia en progresión (cirugía y radioterapia limitadas).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Niña de 5 años con neurofibromatosis tipo 1 (múltiples manchas café con leche y efélides axilares). En control se detecta disminución de la agudeza visual del ojo derecho, defecto pupilar aferente relativo y palidez del disco óptico en el fondo de ojo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio indicado?**
> **A)** Glioma de la vía óptica; resonancia magnética de cerebro y órbitas
> **B)** Ambliopía refractiva; lentes
> **C)** Retinoblastoma; ecografía ocular
> **D)** Neuritis óptica desmielinizante; punción lumbar
> **E)** Catarata congénita; facoemulsificación
> Respuesta A. El glioma de la vía óptica (astrocitoma pilocítico) es el tumor de vía óptica más frecuente en la infancia y se asocia a NF1. Produce pérdida visual, defecto pupilar aferente, atrofia óptica, estrabismo o proptosis. Se estudia con resonancia magnética de cerebro y órbitas. En NF1 se recomienda control oftalmológico anual en la infancia.

6.02.1.027 Tumores de órbita

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.17 Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores de órbita: causa de proptosis unilateral progresiva con o sin diplopía, dolor, desplazamiento del globo y baja visual por compresión del nervio óptico. En adultos, la causa más frecuente de proptosis es la orbitopatía tiroidea; el tumor benigno más común, el hemangioma cavernoso; otros: linfoma, pseudotumor, meningioma, metástasis.
- En niños: proptosis rápidamente progresiva sin fiebre ni foco infeccioso sugiere rabdomiosarcoma (tumor maligno primario más frecuente de la órbita en la infancia); también glioma del nervio óptico, hemangioma capilar y dermoide.
- Diferenciar de celulitis orbitaria (fiebre, dolor, sinusitis, oftalmoplejía dolorosa) y de orbitopatía tiroidea (retracción palpebral, bilateral, Graves).
- Manejo inicial: TAC o RM de órbita urgente y derivación a oftalmología/oncología; biopsia por especialista; no iniciar corticoides ni antibióticos empíricos sin descartar el tumor.
- Seguimiento: derivar de inmediato ante proptosis progresiva en un niño, pérdida visual, diplopía persistente o dolor intenso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 7 años con proptosis unilateral del ojo izquierdo de rápida progresión en 3 semanas, desplazamiento del globo hacia abajo y edema palpebral, sin fiebre, sin dolor importante y sin antecedente de sinusitis ni trauma. Hemograma y PCR normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibiótico endovenoso por celulitis orbitaria
B) TAC o resonancia de órbitas urgente y derivación a oftalmología por sospecha de tumor orbitario maligno (rabdomiosarcoma)
C) Compresas tibias y control en 1 mes
D) Corticoide oral por orbitopatía tiroidea
E) Antihistamínico por edema alérgico

Respuesta B. Una proptosis unilateral rápidamente progresiva en un niño, sin fiebre ni foco infeccioso, debe hacer sospechar rabdomiosarcoma, el tumor orbitario maligno primario más frecuente de la infancia. Requiere imagen urgente (TAC o RM) y biopsia. En adultos, la causa más frecuente de proptosis es la orbitopatía tiroidea y el tumor benigno más común, el hemangioma cavernoso.

6.02.1.028 Tumores de párpado

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma basocelular: tumor maligno palpebral más frecuente (90 %), en párpado inferior y canto interno; nódulo perlado de crecimiento lento con telangiectasias, ulceración central y pérdida de pestañas (madarosis).
- Otros: carcinoma sebáceo (imita chalazión o blefaritis unilateral recidivante, en adulto mayor), espinocelular y melanoma. Sospechar ante lesión palpebral que crece en meses, que sangra, ulcerada o con madarosis, o chalazión recidivante en el mismo lugar.
- Benignos frecuentes: xantelasmas, papilomas, quistes de inclusión; derivar igual si hay duda.
- Manejo inicial: no manipular; protección solar; derivar para biopsia y exéresis con márgenes (cirugía de Mohs o reconstrucción por oculoplástica).
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oculoplástica y control de por vida de la piel.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 112

Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Chalazión crónico
B) Orzuelo interno
C) Carcinoma basocelular
D) Carcinoma espinocelular
E) Melanoma ocular

Respuesta C. Una lesión palpebral de crecimiento lento y progresivo en un adulto, sobre todo si persiste más allá de lo esperable para un chalazión u orzuelo, obliga a descartar un carcinoma basocelular, la neoplasia maligna palpebral más frecuente por lejos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 176

Paciente de 70 años consulta por una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace 1 año y ha crecido progresivamente. Al examen se observa un nódulo perlado, de bordes elevados, con telangiectasias superficiales y una ulceración central, con pérdida de pestañas en la zona. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Orzuelo
B) Chalazión
C) Melanoma
D) Carcinoma basocelular
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta D. El carcinoma basocelular es el tumor maligno palpebral más frecuente (párpado inferior y canto interno). Se presenta como nódulo perlado con telangiectasias, ulceración central y madarosis, de crecimiento lento. Se deriva para biopsia y exéresis con márgenes. Un chalazión que recidiva o no responde en un adulto mayor también debe biopsiarse.

6.02.1.029 Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinoblastoma: tumor intraocular maligno más frecuente de la infancia, por mutación de RB1 (germinal en formas hereditarias bilaterales, autosómica dominante); diagnóstico habitual antes de los 5 años.
- Sospecha: leucocoria (pupila blanca, reflejo rojo ausente o asimétrico, a veces visto en fotos con flash), estrabismo de aparición reciente, ojo rojo doloroso o glaucoma secundario; antecedente familiar de enucleación en la infancia. Diferencial: catarata congénita, retinopatía del prematuro, enfermedad de Coats.
- Manejo inicial en APS: el examen del rojo pupilar con oftalmoscopio es el tamizaje; leucocoria o rojo pupilar asimétrico en cualquier lactante es una urgencia de derivación. No biopsiar ni puncionar el ojo.
- Tratamiento por especialista: quimioterapia sistémica o intraarterial, terapia focal (láser, crioterapia), radioterapia o enucleación según estadio; consejo genético y tamizaje de hermanos y padres.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología oncológica; el pronóstico depende del diagnóstico precoz (supervivencia >90 %), con vigilancia de segundos tumores en la forma hereditaria.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 83

Niño de 8 meses presenta leucocoria del ojo derecho. Como antecedente, su madre usa una prótesis ocular por una pérdida ocular en su infancia, de causa no precisada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía del prematuro
B) Catarata congénita
C) Retinoblastoma
D) Glaucoma congénito
E) Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta C. Leucocoria en un lactante, con antecedente materno de enucleación en la infancia, sugiere retinoblastoma hereditario (mutación germinal de RB1, autosómica dominante). Es el tumor intraocular maligno más frecuente en niños; se presenta con leucocoria o estrabismo. Requiere derivación urgente a oftalmología y consejo genético.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinoblastoma
B) Glaucoma congénito
C) Catarata congénita
D) Retinopatía del prematuro
E) Tumor de órbita

Respuesta A. Diagnóstico: Retinoblastoma (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Glaucoma congénito, Catarata congénita) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la pres

6.02.1.030 Uveítis anterior o posterior

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo · Tema 9.17 Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF · Tema 9.20 Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

QUÉ HAY QUE SABER

- Uveítis anterior (iritis/iridociclitis): ojo rojo con inyección ciliar (halo violáceo periquerático que no blanquea con fenilefrina), dolor moderado, fotofobia intensa con fotofobia consensual, baja de visión, miosis hiporreactiva y células en cámara anterior (fenómeno de Tyndall); la presión intraocular es normal o baja.
- Etiología: idiopática, asociada a HLA-B27 (espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, EII), artritis idiopática juvenil, sarcoidosis, Behçet (panuveítis con hipopión), infecciones (herpes, sífilis, toxoplasmosis, TBC). Uveítis posterior: visión borrosa y miodesopsias sin ojo rojo (toxoplasmosis, CMV, Behçet).
- Tratamiento inicial en APS: derivar de urgencia a oftalmología; ciclopléjico para el dolor y evitar sinequias (nunca mióticos); corticoide tópico solo tras el diagnóstico oftalmológico confirmado (nunca antes por riesgo de úlcera corneal oculta).
- Diferencial: glaucoma agudo (midriasis media fija, ojo pétreo, vómitos), queratitis (fluoresceína positiva) y conjuntivitis (secreción, sin dolor profundo ni baja visual).
- Seguimiento: derivar a oftalmología y reumatología para estudio etiológico (HLA-B27, VDRL, serologías, radiografía de tórax) y tratamiento inmunosupresor en recurrentes o crónicas.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 98

Paciente con psoriasis, disminución de agudeza visual, ojo rojo profundo y fotofobia importante. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Uveítis anterior aguda
B) Epiescleritis
C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
D) Conjuntivitis bacteriana aguda
E) Queratitis herpética

Respuesta A. La psoriasis es una espondiloartropatía asociada a HLA-B27, el mismo grupo de enfermedades reumatológicas que se relaciona con uveítis anterior aguda recurrente. Con ojo rojo profundo, fotofobia intensa y baja de visión, y ese antecedente reumatológico, el diagnóstico más probable es uveítis, no glaucoma ni conjuntivitis.

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 22

Hombre de 24 años consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución que empeora con el reposo en cama y despierta al paciente en la madrugada, asociado a rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico se realiza el Test de Schöber modificado: la distancia inicial de 10 cm entre las marcas de la columna lumbar aumenta únicamente a 12.5 cm a la flexión anterior forzada del tronco. ¿Cómo se interpreta este resultado semiológico?

A) Test normal que descarta patología de columna lumbar
B) Test patológico que indica limitación objetiva de la flexión de la columna lumbar
C) Test patológico que indica hiperlaxitud ligamentosa de columna
D) Test que indica hernia discal lumbar con radiculopatía L5 activa
E) Test no válido que debe repetirse en posición sedente

Respuesta B. En el Test de Schöber modificado, la distancia entre las dos marcas cutáneas lumbares debe incrementarse en al menos 5 cm (alcanzando ≥ 15 cm en total) durante la flexión anterior forzada. Un aumento de solo 2.5 cm (total 12.5 cm) es francamente patológico y demuestra rigidez y limitación objetiva de la movilidad lumbar, hallazgo cardinal en la espondilitis anquilosante.

Pregunta de práctica

Hombre de 31 años consulta por dolor ocular derecho, visión borrosa y fotofobia intensa de 24 horas. Como antecedentes refiere haber presentado múltiples episodios de úlceras dolorosas en la boca (4 episodios en el último año) y úlceras en el escroto que le dejaron cicatrices deprimidas. Al examen oftalmológico con lámpara de hendidura se aprecia inyección ciliar profunda y un nivel blanquecino de 1 mm de exudado leucocitario purulento en la porción inferior de la cámara anterior del ojo derecho (hipopión estéril). En las piernas presenta nódulos eritematosos dolorosos compatibles con eritema nodoso. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A) Enfermedad de Behçet con uveítis anterior e hipopión; hospitalizar de inmediato, indicar corticoides sistémicos a dosis altas y derivar a oftalmología para inmunosupresión con biológicos Anti-TNF
B) Endoftalmitis bacteriana aguda; realizar vitrectomía anterior urgente y vancomicina intravítrea exclusiva
C) Lupus eritematoso sistémico; iniciar hidroxicloroquina oral ambulatoria
D) Artritis reactiva con conjuntivitis purulenta; indicar ciprofloxacino en colirio y paracetamol
E) Síndrome de Sjögren descompensado; indicar lágrimas artificiales y pilocarpina oral

Respuesta A. El cuadro clínico reúne los criterios de la Enfermedad de Behçet: aftas orales recurrentes (≥ 3 al año sin cicatriz), aftas genitales escrotales que dejaron cicatriz permanente, lesiones cutáneas de eritema nodoso y una complicación oftalmológica de extrema gravedad: uveítis anterior aguda con hipopión estéril (acumulación de neutrófilos en cámara anterior). Esta manifestación ocular amenaza gravemente la visión y requiere hospitalización inmediata, pulsos de corticoides y terapia inmunosupresora agresiva con biológicos anti-TNF.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente: FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria).

A) Uveítis anterior
B) Catarata
C) Disgenesia pupilar
D) Endoftalmitis
E) Hemorragia vítrea

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Uveítis anterior). Es una uveítis anterior clásica.. La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 42 años, con antecedente de artritris psoriática e hipertensión arterial, en tratamiento farmacológico, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a fotofobia y disminución de la agudeza visual de dicho ojo. Al examen físico tiene ojo rojo bilateral, mayor al lado izquierdo, con marcada fotofobia en dicho lado, al examen con linterna. Su agude visual es 20/25 a derecha y 20/40 a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Uveítis aguda
B) Conjuntivitis viral
C) Glaucoma agudo
D) Neuritis óptica
E) Glaucoma crónica

Respuesta C. Diagnóstico: Glaucoma agudo (opción C). La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 34 años, tienen antecedente de úlceras orales a repetición y artralgias. Además, presentó una úlcera genital hace algunas semanas. Consulta por dolor en el ojo derecho, asociado a visión borrosa, de dos días de evolución. Al examen físico, se aprecia marcado enrojecimiento del ojo derecho, con agudeza visual 20/100. El diagnóstico más probable es:

A) Úlcera corneal
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Conjuntivitis viral
D) Uveítis
E) Queratitis aguda

Respuesta D. Tiene una enfermedad de Behçet, que se asocia a uveítis, al igual que las PEA y las EII. La A, C y E no afectan la agudeza visual. La B no tiene ojo rojo.

6.02.1.031 Vicios de refracción en personas de 65 años o más

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Presbicia y vicios de refracción en mayores de 65 años: dificultad para ver de cerca (síndrome de los brazos cortos), a veces visión borrosa de lejos por hipermetropía, miopía o astigmatismo no corregidos; sin dolor ni ojo rojo.
- Específico: agudeza visual con tabla de Snellen (lejos y cerca) y agujero estenopeico: si mejora, se confirma vicio de refracción; reflejo rojo pupilar normal hace improbable catarata. Si no mejora, derivar por catarata, maculopatía o glaucoma.
- Tratamiento inicial: sospecha GES de vicios de refracción en personas de 65 años o más (evaluación y entrega de lentes ópticos); derivar con receta para refracción y lentes; mientras tanto, buena iluminación.
- En cada evaluación descartar causas orgánicas frecuentes del adulto mayor: catarata, glaucoma crónico (fondo de ojo y tonometría), degeneración macular y retinopatía diabética.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/optometría para refracción y entrega de lentes; control periódico de agudeza visual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, beneficiario de FONASA, consulta en su CESFAM porque desde hace 2 años debe alejar el diario para leer y ve borroso de cerca, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual de lejos es 20/30 bilateral y mejora con agujero estenopeico. El rojo pupilar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar colirio lubricante y control en 1 año
B) Derivar de urgencia por sospecha de glaucoma agudo
C) Derivar con sospecha GES de vicio de refracción en mayores de 65 años para evaluación y entrega de lentes ópticos
D) Solicitar resonancia magnética de cerebro
E) Derivar a cirugía de catarata

Respuesta C. Dificultad para la visión cercana que se corrige alejando el texto es presbicia, y la mejoría con estenopeico confirma un vicio de refracción. Las personas de 65 años o más tienen garantía GES para el diagnóstico y la entrega de lentes ópticos. El rojo pupilar normal hace improbable una catarata significativa.

Situaciones clínicas de urgencia 10 códigos

6.02.2.001 Causticaciones oculares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.16 Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

QUÉ HAY QUE SABER

- Cauticación ocular: única urgencia oftalmológica en que se trata antes de hacer la historia. Álcalis (soda cáustica, cal viva, cemento, amoníaco) producen necrosis por licuefacción sin barrera y penetran a cámara anterior, iris y cristalino en minutos: son los más graves. Ácidos (batería, muriático) causan necrosis por coagulación con escara que limita la penetración (excepción: ácido fluorhídrico, que actúa como álcali).
- Sospecha: contacto reciente con químico, dolor intenso, blefarospasmo, lagrimeo, ojo rojo y baja visual; la isquemia del limbo (ojo blanco sin vasos) marca el pronóstico: es necrosis, no mejoría.
- Tratamiento inicial inmediato: instilar anestésico tópico y lavar con suero fisiológico o Ringer lactato (agua corriente si no hay) 1–2 litros durante 20–30 minutos, evertir ambos párpados y barrer los fondos de saco con tórula (extraer partículas de cal o cemento); controlar con tira de pH hasta 7–7,5 y repetir a los 10 minutos.
- Errores: demorar el lavado para tomar la ficha, medir la agudeza visual o esperar al oftalmólogo; intentar neutralizar el álcali con un ácido (reacción exotérmica). No usar corticoides ni ocluir antes del lavado.
- Después del lavado: ciclopléjico, lubricación, analgesia y derivación urgente a oftalmología; complicaciones: leucoma, simblefaron, glaucoma, necesidad de trasplante de limbo.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 173

Un paciente consulta en el servicio de urgencia porque hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas, y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el izquierdo tiene agudeza visual de 20/80. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ungüento antibiótico y parche ocular
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Hielo local
D) Corticoides tópicos
E) Analgésicos

Respuesta B. La causticación ocular se maneja con lavado profuso con suero fisiológico o agua por 30 minutos, sin importar la agudeza visual ya perdida. Esto es distinto de la sospecha de perforación ocular, donde no se toca el ojo y solo se dan analgésicos y antibióticos endovenosos mientras se deriva con urgencia.

Pregunta de práctica

Trabajador de una faena de construcción, de 29 años, llega corriendo a la urgencia rural gritando de dolor, luego de que un saco de cemento y cal viva le estallara en la cara hace 10 minutos. Presenta blefarospasmo intenso y lagrimeo. El técnico de enfermería pregunta si debe tomar los signos vitales y la agudeza visual antes de ingresarlo al box. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tomar los signos vitales y la agudeza visual antes de iniciar cualquier tratamiento
B) Iniciar de inmediato irrigación ocular profusa con suero fisiológico, sin esperar ningún otro trámite
C) Esperar la llegada del oftalmólogo de turno antes de tocar los ojos
D) Aplicar un ungüento con corticoides y ocluir con parche estéril
E) Instilar un colirio con ácido acético diluido para neutralizar la cal

Respuesta B. La cal viva y el cemento son álcalis, y en toda quemadura química ocular la conducta inaplazable es la irrigación ocular inmediata y profusa. No se debe demorar el lavado por signos vitales, agudeza visual ni la llegada del especialista, y está contraindicado intentar neutralizar con otro químico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 175 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 30 minutos le saltó una solución de soda cáustica caliente a la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

A) Analgésicos
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Antibióticos tópicos
D) Corticoides tópicos
E) Parche ocular

Respuesta B. Las causticaciones oculares (con ácidos, álcalis y otros irritantes) se manejan con lavado abundante con suero fisiológico o agua, por 30 minutos y luego ATB tópicos. El parche es discutible, ya que da miedo que se adhiera el párpado al globo ocular.

6.02.2.002 Contusión ocular

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Contusión ocular (trauma cerrado): puñetazo, pelota, golpe contuso con cuadro variable: hematoma palpebral, hiposfagma, hifema, midriasis traumática, catarata, subluxación del cristalino, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina o neuropatía óptica traumática. Estudio: agudeza visual, pupilas, motilidad, fondo de ojo.
- Fractura por estallido del piso de la órbita (blow-out): diplopía al mirar hacia arriba, limitación de la elevación (atrapamiento del recto inferior), enoftalmos, equimosis periorbitaria e hipoestesia de la mejilla y labio superior (nervio infraorbitario); confirmar con TAC de órbitas.
- Descartar siempre globo abierto: pupila en gota, cámara anterior plana, Seidel positivo, hiposfagma 360° con quemosis; si hay sospecha, no presionar el ojo, no medir presión ni usar colirios o parche compresivo: concha rígida y derivar de urgencia.
- Tratamiento inicial: compresas frías, analgesia con paracetamol (sin AINE si hay hifema), reposo con cabecera elevada, aseo de heridas y profilaxis antitetánica; indicar no sonarse la nariz en sospecha de fractura orbitaria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología (GES trauma ocular) con carácter urgente; controles de presión intraocular y fondo de ojo por desprendimiento tardío.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 35 años recibe un puñetazo en el ojo derecho hace 2 horas. Presenta equimosis y edema palpebral. Al examen: agudeza visual 20/25, diplopía al mirar hacia arriba, limitación de la elevación del ojo derecho e hipoestesia de la mejilla y el labio superior derecho. Cámara anterior sin sangre y pupilas isocóricas reactivas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Desprendimiento de retina traumático
B) Fractura por estallido del piso de la órbita con atrapamiento del recto inferior
C) Parálisis del tercer par craneano
D) Hifema traumático
E) Neuropatía óptica traumática

Respuesta B. Tras una contusión orbitaria, la diplopía con limitación de la mirada hacia arriba (atrapamiento del recto inferior) y la hipoestesia infraorbitaria (lesión del nervio infraorbitario) son típicas de la fractura por estallido del piso orbitario. Se confirma con tomografía computada de órbitas.

6.02.2.003 Desprendimiento de retina

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.10 Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

QUÉ HAY QUE SABER

- Desprendimiento de retina regmatógeno (>90 %): desgarro periférico por tracción del vítreo, con paso de vítreo licuado al espacio subretiniano. Factores: miopía magna (principal), cirugía de catarata previa, trauma. Traccional (retinopatía diabética proliferativa) y exudativo (tumor, inflamación, preeclampsia) no tienen desgarro.
- Secuencia clásica: miodesopsias bruscas (moscas volantes), fotopsias (destellos periféricos) y luego una cortina o sombra fija que avanza desde la periferia hacia el centro; caída brusca de la visión central cuando se despega la mácula. Es indoloro y el ojo está blanco.
- Sospecha en APS: fondo de ojo con retina gris, levantada y ondulada; confirmar con oftalmoscopía indirecta y pupila dilatada (el especialista). Diferenciar de hemorragia vítrea (pérdida súbita con humo rojizo, sin cortina).
- Tratamiento inicial: reposo absoluto en semi-Fowler o decúbito, régimen cero por la cirugía inminente, sin colirios, y derivación de extrema urgencia (mismo día) a un centro oftalmológico; con mácula aplicada operar en <24–48 horas (mejor pronóstico), con mácula desprendida en 7–10 días.
- Seguimiento por oftalmología: láser profiláctico si solo hay desgarro; vitrectomía pars plana o cerclaje escleral en desprendimiento establecido (GES desprendimiento de retina regmatógeno no traumático); posición boca abajo 1–2 semanas tras vitrectomía con gas.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento de retina traccional? **¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre ambos?**

A) El regmatógeno requiere una rotura que permite el paso de vítreo líquido; el traccional lo producen membranas fibrovasculares sin desgarro
B) El regmatógeno es doloroso y con ojo rojo, mientras que el traccional es indoloro
C) El traccional se opera siempre con láser superficial y el regmatógeno solo con corticoides orales
D) El regmatógeno se produce por exudados inflamatorios y el traccional por hipertensión intraocular
E) No existe diferencia; son dos términos sinónimos para la misma patología

Respuesta A. El desprendimiento regmatógeno exige una rotura de la retina, por la que el vítreo licuado penetra al espacio subretiniano. El traccional se origina por membranas fibróticas que tiran de la retina sin que exista una rotura inicial, típicas de la retinopatía diabética proliferativa.

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con miopía de seis dioptrías consulta porque hace 48 horas comenzó a ver destellos luminosos en el rabillo del ojo derecho, como flashes de cámara, junto con muchos puntos negros flotantes. Desde esta mañana nota una sombra oscura fija en la parte inferior del campo visual derecho, que ha ido creciendo hacia el centro, como si cerraran una persiana. No refiere dolor, trauma ni ojo rojo. Al examen: ojo blanco, pupila fotorreactiva, agudeza visual conservada.
¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar un colirio antiinflamatorio y control ambulatorio en una semana
B) Reposo absoluto, régimen cero y derivación de urgencia para cirugía GES
C) Tranquilizar al paciente: las moscas volantes son siempre benignas
D) Solicitar una resonancia magnética de órbita antes de decidir
E) Indicar reposo en el domicilio y control en un mes

Respuesta B. Fotopsias y miodesopsias agudas seguidas de una sombra en cortina que progresa, en un paciente miope y con ojo blanco indoloro, es el cuadro clásico de desprendimiento de retina regmatógeno. La agudeza visual conservada sugiere que la mácula aún está aplicada, lo que hace de esto una emergencia quirúrgica de horas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias: a. Desprendimiento de retina

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciale

6.02.2.004 Disminución de la visión (lenta vs súbita)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.8 Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación · Tema 15.10 Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo · Tema 15.11 Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

QUÉ HAY QUE SABER

- Disminución de la visión: primero separar lenta (semanas a años) de súbita (segundos a días), unilateral de bilateral, y dolorosa de indolora, y medir agudeza visual con estenopeico (mejora = vicio de refracción).
- Lenta e indolora: vicio de refracción y presbicia (mejoran con estenopeico), catarata (rojo pupilar atenuado, deslumbramiento nocturno, miopización), glaucoma crónico (campo en túnel, excavación >0,5), DMAE seca y retinopatía diabética.
- Súbita e indolora: oclusión de la arteria central de la retina (segundos, mancha rojo cereza, pupila de Marcus Gunn; descartar arteritis de células gigantes), oclusión venosa (hemorragias en llamarada), desprendimiento de retina (moscas, fotopsias, cortina), hemorragia vítrea (diabético, humo rojizo, pierde el rojo pupilar), DMAE húmeda (metamorfopsia, escotoma central) y neuropatía óptica isquémica o neuritis (dolor al mover el ojo).
- Súbita dolorosa con ojo rojo: glaucoma agudo, uveítis, queratitis y endoftalmitis (todas urgencias).
- Tratamiento inicial: orientar la causa, tratar lo urgente (adrenalina no, ver cada cuadro: manitol/acetazolamida/timolol en glaucoma agudo; reposo y derivación en desprendimiento; corticoides en sospecha de arteritis) y derivar a oftalmología el mismo día; controlar diabetes e hipertensión.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años con catarata bilateral conocida, en lista de espera de cirugía, consulta porque hace 6 horas perdió casi por completo la visión del ojo derecho, en forma brusca y sin dolor. Hasta ayer veía con dificultad, pero en forma estable. Agudeza visual: cuenta dedos a 1 metro en el ojo derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Atribuirlo a progresión de la catarata y mantener la espera habitual
B) Adelantar la cirugía de catarata en forma electiva
C) Indicar lentes nuevos y control en 3 meses
D) Derivar a oftalmología de urgencia el mismo día
E) Colirio lubricante y control en 1 semana

Respuesta D. La catarata produce pérdida visual lenta y progresiva en meses o años, nunca en horas. Una disminución súbita e indolora obliga a buscar otra causa, como oclusión arterial o venosa retiniana, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, y requiere evaluación oftalmológica urgente.

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años, fumador, consulta porque hace 4 días nota en el ojo derecho que las líneas rectas, como los marcos de las puertas, se ven onduladas, y una mancha oscura en el centro de la visión. No tiene dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/100 en el ojo derecho, que no mejora con agujero estenopeico. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Catarata senil
B) Glaucoma crónico
C) Degeneración macular relacionada con la edad neovascular
D) Vicio de refracción
E) Conjuntivitis viral

Respuesta C. Metamorfopsia y escotoma central de instalación en días, en un adulto mayor fumador, sugieren degeneración macular neovascular, o húmeda. Es una pérdida visual subaguda que requiere derivación urgente a oftalmología para terapia antiangiogénica intravítrea. La catarata y el glaucoma crónico producen pérdida lenta y sin metamorfopsia.

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años, hipertenso, con fibrilación auricular en tratamiento irregular, consulta por pérdida visual súbita y completa del ojo izquierdo, iniciada hace 2 horas al despertar. Refiere que se apagó la luz de golpe en ese ojo, sin dolor ni traumatismo. Al examen: ojo blanco, agudeza visual limitada a percepción de luz, defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. El fondo de ojo muestra palidez retiniana difusa con un punto rojo brillante en la fóvea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar reposo domiciliario y control ambulatorio en una semana
B) Iniciar maniobras de rescate ocular, derivar de urgencia y estudiar fuente embólica
C) Indicar colirio de corticoide y antiinflamatorio oral
D) Tranquilizar al paciente: la fibrilación auricular no se relaciona con la visión
E) Solicitar campo visual computarizado antes de decidir cualquier conducta

Respuesta B. Pérdida monocular súbita, catastrófica e indolora, con defecto pupilar aferente y mancha rojo cereza foveal, en un paciente con fibrilación auricular: oclusión de la arteria central de la retina de origen cardioembólico. La conducta es intentar maniobras de rescate, derivar de urgencia y hospitalizar para estudio vascular y anticoagulación, previniendo un accidente cerebrovascular futuro.

Pregunta de práctica

Una mujer de 55 años, hipertensa, presenta disminución progresiva de la visión de su ojo izquierdo en las últimas 24 horas. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas masivas en llama en los cuatro cuadrantes, venas tortuosas muy dilatadas y exudados algodonosos. Tres meses después consulta por dolor ocular insoportable y ojo rojo intenso, con la presión intraocular muy elevada. **¿Qué complicación ha desarrollado?**

A) Glaucoma agudo por cierre angular primario
B) Glaucoma neovascular secundario a la isquemia retiniana
C) Endoftalmitis endógena bacteriana
D) Desprendimiento de retina exudativo
E) Uveítis anterior hipertensiva

Respuesta B. El cuadro inicial es una oclusión de la vena central de la retina de tipo isquémica. La falta de perfusión estimula la liberación masiva de VEGF, que produce neovasos en el iris y el ángulo, bloqueando la malla trabecular: es el glaucoma neovascular, o glaucoma de los cien días, que aparece típicamente a los tres meses.

6.02.2.005 Glaucoma agudo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo · Tema 15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma agudo de ángulo cerrado: ojo pequeño hipermétrope con cámara anterior estrecha, edad avanzada/catarata; gatillado por midriasis media (penumbra, estrés, anticolinérgicos, topiramato). Bloqueo pupilar: PIO sube a 50–80 mmHg.
- Sospecha: cefalea unilateral brutal con náuseas y vómitos (se confunde con migraña o ACV), baja brusca de visión y halos de colores; ojo rojo con inyección ciliar, córnea en vidrio esmerilado, pupila en midriasis media fija y arreactiva, y ojo pétreo a la palpación comparado con el otro.
- Tratamiento inicial en urgencia: bajar la PIO de inmediato con manitol EV, acetazolamida oral o EV y timolol tópico, más corticoide tópico (prednisolona) para la inflamación; analgesia y antieméticos; pilocarpina solo cuando la presión ya haya bajado (con PIO muy alta el esfínter está isquémico). Derivar urgente.
- Contraindicado: midriáticos (atropina, tropicamida) en ángulo estrecho no tratado, que agravan el bloqueo y pueden dejar ciego. Diferenciar de uveítis anterior (miosis, PIO normal o baja, sin vómitos).
- Tratamiento definitivo por oftalmología: iridotomía periférica láser YAG siempre en ambos ojos (el ojo sano tiene 50–70 % de riesgo de crisis).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 80

Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, que trata profilácticamente con topiramato. Refiere estar con más estrés del habitual. Hace dos horas comienza con cefalea intensa, de localización periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo izquierdo enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. **La conducta inicial más adecuada es:**

A) Manitol endovenoso
B) Clorpromazina endovenosa
C) Ketorolaco endovenoso
D) Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo
E) Carbamazepina oral

Respuesta A. Una migrañosa en profilaxis con topiramato, con dolor periocular, náuseas, ojo rojo y pupila fija en semimidriasis: glaucoma agudo de ángulo cerrado, un efecto adverso conocido del topiramato. Se trata con manitol endovenoso, mióticos e iridotomía. Tratarla como crisis de migraña es la trampa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 149

Un paciente de 48 años, con antecedente de hipermetropía, consulta por dolor en el ojo izquierdo, muy intenso, irradiado a la frente. Al examen físico, se aprecia eritema periquerático del ojo izquierdo, con pupila midriática arreactiva y se aprecia opacidad corneal. El ojo derecho tiene visión 20/20, mientras que el ojo izquierdo tiene visión borrosa, que solo es capaz de contar dedos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Conjuntivitis
B) Uveítis aguda
C) Queratitis viral aguda
D) Trombosis de la vena central de la retina
E) Glaucoma agudo

Respuesta E. Hipermetropía como factor de riesgo, dolor intenso irradiado a la frente, eritema periquerático, pupila midriática arreactiva, opacidad corneal y caída severa de la agudeza visual son el cuadro clásico del glaucoma agudo de ángulo cerrado. La hipermetropía predispone porque el ojo es más pequeño y el ángulo, más estrecho.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 3

Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma agudo
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Cefalea cluster
D) Celulitis orbitaria
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta A. Hipermétrope con cefalea unilateral intensa, náuseas, ojo rojo profundo y midriasis fija arreactiva: glaucoma agudo de ángulo cerrado, el diagnóstico que hay que descartar antes de pensar en una causa neurológica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 144

Una paciente de 50 años consulta por dolor ocular izquierdo de inicio agudo, asociado a visión borrosa. Al examen físico destaca ojo rojo periquerático y pupila midriática arreactiva; la agudeza visual está disminuida en el ojo izquierdo respecto al derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Uveítis aguda
B) Endoftalmitis
C) Queratitis aguda
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

Respuesta E. Dolor agudo, visión borrosa, ojo rojo periquerático y midriasis arreactiva: glaucoma agudo. La midriasis fija lo distingue de la uveítis, que da miosis; ni la escleritis ni la queratitis producen ese cambio pupilar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 80

Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, tratada profilácticamente con topiramato, refiere estar con más estrés del habitual. Hace 2 horas comienza con cefalea intensa, periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo derecho enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Manitol endovenoso
B) Clorpromazina endovenosa
C) Ketorolaco endovenoso
D) Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo
E) Carbamazepina oral

Respuesta A. El topiramato puede precipitar un glaucoma agudo de ángulo cerrado bilateral por efecto anticolinérgico e inflamación ciliar; el cuadro clínico, con pupila fija en semimidriasis, lo confirma. La conducta inicial es manitol endovenoso, dentro de la tríada hipotensora.

6.02.2.006 Hemorragia vítrea

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia vítrea: sangre en el vítreo, causa más frecuente de pérdida súbita e indolora de visión en el diabético (neovasos de la retinopatía proliferativa); otras causas: desgarro retiniano, oclusión venosa, trauma y degeneración macular neovascular.
- Sospecha: pérdida brusca de visión con «humo», telarañas o tinte rojizo, moscas volantes; ojo blanco y sin dolor; rojo pupilar disminuido o ausente, con agudeza visual desde cuenta dedos a movimiento de manos. Diferenciar del desprendimiento de retina (cortina que avanza con fotopsias previas).
- Tratamiento inicial en APS: derivar a oftalmología con carácter urgente; reposo con la cabeza elevada (permite que la sangre decante), suspender antiagregantes/anticoagulantes cuando sea posible y controlar la glicemia; no dar colirios.
- Estudio por especialista: ecografía ocular modo B (para descartar desprendimiento o desgarro asociado, ya que no se ve el fondo), fotocoagulación láser, anti-VEGF o vitrectomía si no se reabsorbe.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; control metabólico estricto y fondo de ojo anual de por vida en diabéticos.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 177

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La agudeza visual del ojo derecho es normal. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 9,2%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuritis óptica isquémica
B) Desprendimiento de retina
C) Hemorragia vítrea
D) Trombosis de la arteria central
E) Edema macular

Respuesta C. Diabético mal controlado con pérdida visual brusca e indolora y rojo pupilar negativo: hemorragia vítrea por rotura de neovasos de una retinopatía proliferativa. La pérdida del rojo pupilar es el signo que la distingue.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 157

Una paciente de 56 años, diabética de larga data, mal controlada, con nefropatía diabética en etapa IV, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma
B) Edema macular
C) Uveítis
D) Trombosis de la vena central de la retina
E) Hemorragia vítrea

Respuesta E. La nefropatía avanzada indica daño microvascular extenso y sugiere una retinopatía proliferativa, que se complica con hemorragia vítrea: pérdida súbita e indolora. Al examen se perdería el rojo pupilar.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 157

Una paciente de 56 años, diabética de larga data y mal controlada, con nefropatía diabética en etapa 4, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma
B) Edema macular
C) Uveítis
D) Trombosis de la vena central de la retina
E) Hemorragia vítrea

Respuesta E. El antecedente de diabetes de larga data con daño renal avanzado sugiere una microangiopatía sistémica severa, compatible con una retinopatía diabética proliferativa ya complicada con hemorragia vítrea, la causa más frecuente de pérdida súbita e indolora de la visión en el diabético de larga data.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 177

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso, presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca una hemoglobina glicosilada de nueve coma dos por ciento. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuritis óptica isquémica
B) Desprendimiento de retina
C) Hemorragia vítrea
D) Trombosis de la arteria central de la retina
E) Edema macular

Respuesta C. La pérdida súbita de visión reducida a percepción de movimientos de mano, con pérdida del reflejo rojo pupilar y una hemoglobina glicosilada muy elevada, es una hemorragia vítrea. El edema macular tarda días en instalarse y no borra el rojo pupilar; la oclusión arterial da mancha rojo cereza, no pérdida del rojo pupilar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 179

Paciente de 60 años, diabético e hipertenso mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. Con ese ojo solo cuenta dedos. No hay alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trombosis de la vena central de la retina
B) Desprendimiento de retina
C) Neuritis óptica
D) Embolia de arteria central de la retina
E) Hemorragia vítrea

Respuesta E. Pérdida visual súbita e indolora con rojo pupilar disminuido (sangre en el vítreo que impide ver el fondo) en un diabético mal controlado es hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa. Se deriva a oftalmología: ecografía ocular para descartar desprendimiento de retina, y fotocoagulación láser, antiangiogénicos o vitrectomía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 68 años, diabético de larga data, fumador, presenta pérdida brusca de la visión del ojo derecho, sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto occipital
B) Desprendimiento de retina
C) Hemorragia vítrea
D) Degeneración macular
E) Edema macular

Respuesta C. Es una HV clásica, que es la causa de ceguera en la retinopatía diabética. La pérdida de rojo pupilar es un signo característico, aunque no se mencione. El infarto occipital daría hemianopsia homónima contralateral. El DR sí pierde la visión, pero suele ser como una caída de telón o levantamiento de pared y estar precedido de fotopsias y entopsias. La DMRE es crónica y la AV disminuye lentamente.

6.02.2.007 Herida penetrante o perforante ocular

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Herida penetrante o perforante ocular (trauma abierto): herida de espesor total de córnea o esclera por objeto cortante (clavo, vidrio, balín) o cuerpo extraño de alta velocidad (martillar metal sin protección); perforante si tiene orificio de salida; ruptura por objeto romo.
- Signos de sospecha: pupila en gota que apunta a la herida, cámara anterior plana o anormal, hipotonía, signo de Seidel positivo, protrusión de iris/coroides/vítreo, hiposfagma masivo en 360° con quemosis tras trauma contuso; baja de visión.
- Tratamiento inicial (GES trauma ocular grave): proteger con concha rígida fenestrada apoyada en el reborde óseo, sin comprimir el globo; régimen cero, cabecera a 30°, analgesia y antieméticos EV (evitar vómito/Valsalva), antibiótico EV (ceftazidima + vancomicina) y profilaxis antitetánica; derivar de urgencia a pabellón.
- Prohibido: palpar el ojo, medir la presión (tonometría), aplicar pomadas o colirios, parche compresivo; la resonancia magnética está contraindicada si se sospecha cuerpo extraño metálico: el examen de elección es TAC de órbita sin contraste con cortes finos.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología para reparación quirúrgica; riesgo de endoftalmitis, desprendimiento de retina y oftalmía simpática.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2, y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. **¿Cuál de las siguientes conductas representa una acción estrictamente contraindicada en este paciente?**

A) Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva
B) Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa
C) Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular
D) Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología
E) Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

Respuesta C. Ante signos inequívocos de globo ocular abierto (pupila en gota con herniación de tejido uveal y atalamia), medir la presión intraocular está estrictamente contraindicado: el contacto del tonómetro presiona el ojo y puede expulsar el contenido intraocular. La protección con concha rígida, la analgesia y antieméticos EV, y el ayuno son conductas mandatorias.

6.02.2.008 Heridas de párpados

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Heridas de párpados: laceraciones, mordeduras de perro o cortes; siempre descartar lesión del globo ocular (agudeza visual, pupila, fluoresceína, rojo pupilar) antes de suturar.
- Específico: reconocer heridas de espesor completo, que comprometen el borde libre o el tarso, y las mediales al punto lagrimal (riesgo de sección del canalículo y epífora crónica) o con lesión del elevador (ptosis).
- Tratamiento inicial: aseo con suero, hemostasia suave, analgesia, profilaxis antitetánica y, en mordeduras, antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y evaluación de profilaxis antirrábica; cubrir con gasa húmeda sin comprimir si se sospecha globo abierto.
- Heridas superficiales y limpias fuera del borde pueden ser suturadas por el médico entrenado; las de espesor completo, del borde palpebral o de la vía lagrimal se derivan a oftalmología para reparación en 24–48 horas para evitar deformidades.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oculoplástica; control de cicatrización, retiro de puntos a los 5–7 días en la cara y vigilancia de epífora.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Niño de 6 años sufre mordedura de perro en la cara. Tiene una herida de espesor completo en el tercio medial del párpado inferior derecho, entre el punto lagrimal y el canto interno. El globo ocular parece indemne. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Sutura simple de piel en el servicio de urgencia
> **B)** Parche ocular compresivo y control en 1 semana
> **C)** Dejar cicatrizar por segunda intención
> **D)** Cierre con adhesivo tisular
> **E)** Aseo, profilaxis antibiótica y antirrábica según corresponda, y derivación a oftalmología para reparación con evaluación y reconstrucción de la vía lagrimal (canalículo)
>
> Respuesta E. Las heridas palpebrales mediales al punto lagrimal pueden seccionar el canalículo, y las que comprometen el borde libre o son de espesor completo requieren reparación por especialista para evitar epífora crónica y deformidades. Ante una herida palpebral siempre se descarta lesión del globo. Las mordeduras requieren además aseo, antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y evaluación de profilaxis antirrábica y antitetánica.

6.02.2.009 Parálisis III par + midriasis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Parálisis del III par con midriasis: ptosis completa, ojo desviado hacia abajo y afuera (diplopía) y pupila dilatada, fija y arreactiva a la luz directa y consensual (lesión eferente); si se acompaña de cefalea intensa, es compresión por aneurisma de la arteria comunicante posterior hasta demostrar lo contrario.
- Específico: una paresia aislada del III par con pupila comprometida es compresiva (aneurisma, tumor, uncus en hipertensión endocraneana); la isquémica microvascular (diabetes, HTA) respeta la pupila (pupila normal). Diferenciar del defecto aferente (la pupila sí se contrae con la luz del ojo sano) y del síndrome de Horner.
- Tratamiento inicial: emergencia: TAC sin contraste y angio-TAC cerebral urgentes (descartar hemorragia subaracnoidea y aneurisma), control neurológico y de presión arterial, y derivación inmediata a centro con neurocirugía.
- En hemorragia subaracnoidea: reposo, analgesia, nimodipino, PA sistólica <160 mmHg hasta asegurar el aneurisma (coils o clipaje en 24–72 horas).
- Seguimiento: derivar a neurología/neurocirugía; no esperar la evolución ni dar alta con cefalea y midriasis fija.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años consulta por cefalea intensa retroocular derecha de 1 día y visión doble. Al examen tiene ptosis palpebral derecha, ojo desviado hacia abajo y afuera y pupila derecha midriática arrefléctica. Sin rigidez de nuca. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Diagnosticar parálisis microvascular del III par y controlar en 3 meses
B) Angio-TAC o angiorresonancia cerebral urgente por sospecha de aneurisma de la arteria comunicante posterior
C) Iniciar corticoides por neuritis
D) Indicar parche ocular y control con oftalmología
E) Prueba de hielo para miastenia

Respuesta B. Una parálisis del III par con midriasis (compromiso pupilar) y cefalea sugiere compresión de las fibras parasimpáticas periféricas por un aneurisma de la comunicante posterior, con riesgo de rotura: requiere angio-TAC o angiorresonancia urgente. La parálisis microvascular (diabetes, HTA) típicamente respeta la pupila. La miastenia nunca compromete la pupila.

6.02.2.010 Úlcera corneal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera corneal: defecto epitelial con infiltrado del estroma; ojo rojo con inyección ciliar, dolor intenso, fotofobia, blefarospasmo, lagrimeo y baja de agudeza visual; infiltrado blanquecino con fluoresceína positiva y, en graves, hipopión.
- Específico: factor de riesgo clave es el uso de lentes de contacto blandos (dormir con ellos, higiene con agua); también trauma, cuerpo extraño y herpes (dendrita). Confirmar con fluoresceína bajo luz azul de cobalto; no usar anestésico tópico repetido.
- Tratamiento inicial: retirar el lente y guardarlo para cultivo, colirio antibiótico de amplio espectro (fluoroquinolona; reforzados vancomicina + ceftazidima en el centro especializado), ciclopléjico para el dolor y analgesia oral; no ocluir con parche. Herpética: aciclovir tópico.
- JAMÁS corticoides tópicos en úlcera sin diagnóstico oftalmológico (perforación). Complicaciones: perforación, endoftalmitis y leucoma.
- Seguimiento: derivar de urgencia (mismo día) a oftalmología para raspado, cultivo y tratamiento reforzado; control cada 24 horas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 107

Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a epífora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 milímetros de diámetro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Conjuntivitis bacteriana
B) Úlcera corneal
C) Uveítis aguda
D) Glaucoma agudo
E) Blefaritis

Respuesta B. Usuaria de lentes de contacto con dolor ocular, inyección periquerática y una zona de opacidad corneal focal es una úlcera corneal, el diagnóstico que hay que sospechar siempre en portadores de lentes con ojo rojo doloroso. La conjuntivitis no da opacidad corneal ni dolor real; la uveítis y el glaucoma no explican la opacidad focal de la córnea.

Conocimientos generales 6 códigos

6.02.3.001 Accidentes del trabajo

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Los traumatismos oculares laborales (esmeril, soldadura, martillar metal, químicos, proyección de partículas) son accidentes del trabajo según la Ley 16.744: se emite la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y se deriva al organismo administrador (mutual o ISL), que cubre atención, licencia y prestaciones.

- Prevención: uso obligatorio de elementos de protección personal (lentes, antiparras o careta) provistos por el empleador, estación lavaojos en lugares con químicos, capacitación y fiscalización.
- Cuerpo extraño superficial: extraer, antibiótico tópico y control; si hubo alta velocidad (martillar metal) sospechar cuerpo extraño intraocular y pedir TAC de órbita (nunca resonancia); en causticación irrigar abundantemente de inmediato.
- Soldadores: queratitis actínica (dolor bilateral horas después de la exposición, cura en 24–48 horas con lubricantes); no entregar anestésico tópico para uso repetido.
- Derivar a oftalmología los casos con baja de visión, herida penetrante, causticación o cuerpo extraño no removible; el seguimiento y la rehabilitación quedan a cargo del organismo administrador.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años, trabajador de una maestranza, consulta en urgencia por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho tras usar un esmeril sin lentes de protección hace 3 horas. Al examen hay un cuerpo extraño metálico superficial en la córnea con anillo de óxido incipiente. **Además del manejo del cuerpo extraño, ¿cuál es la conducta administrativa y preventiva correcta?**

A) Considerarlo accidente del trabajo: emitir la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y derivar a su organismo administrador (mutual o ISL); reforzar el uso obligatorio de protección ocular
B) Licencia por enfermedad común con cargo a su previsión de salud
C) No requiere notificación porque es una lesión leve
D) Derivar a COMPIN para calificar enfermedad profesional
E) Recomendar al trabajador cambiar de oficio

Respuesta A. Las lesiones oculares por esmeril, soldadura o químicos en el trabajo son accidentes del trabajo (Ley 16.744): se emite la DIAT y la atención, licencia y prestaciones son de cargo del organismo administrador. Son prevenibles con elementos de protección personal (lentes o careta), que el empleador debe proporcionar. Con radiografía se descarta cuerpo extraño intraocular si hubo alta velocidad.

6.02.3.002 Diabetes

Dónde se enseña: Tema 15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes y ojo: la retinopatía diabética es asintomática hasta etapas avanzadas, por lo que el tamizaje es la medida preventiva clave; además la diabetes acelera la catarata y aumenta glaucoma, oclusiones vasculares y neuropatías ópticas.
- Tamizaje GES: DM2 con fondo de ojo con pupila dilatada (o retinografía) al diagnóstico y luego anual de por vida; DM1 a los 5 años del debut y luego anual; en embarazadas diabéticas, control por trimestre.
- Visión borrosa fluctuante en hiperglicemia: cambio refractivo transitorio por hidratación del cristalino, mejora con estenopeico; no recetar lentes hasta estabilizar la glicemia.
- Prevención: control estricto de glicemia (HbA1c), presión arterial y lípidos; suspender tabaco; educar en síntomas de alarma (moscas volantes, sombra, pérdida súbita de visión).
- Derivar a oftalmología: cualquier grado de retinopatía, edema macular, baja de visión no explicada o fondo de ojo no valorable (catarata, hemorragia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años, recién diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 con glicemia de 380 mg/dL, consulta por visión borrosa bilateral fluctuante de 3 semanas, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual mejora con agujero estenopeico y el fondo de ojo con dilatación pupilar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su visión?**

A) Recetar lentes ópticos de inmediato con la refracción actual
B) Solicitar angiografía con fluoresceína
C) Derivar de urgencia por sospecha de retinopatía proliferativa
D) Iniciar fotocoagulación láser preventiva
E) Lograr el control glicémico y diferir la receta de lentes hasta que la glicemia se estabilice, manteniendo el fondo de ojo anual

Respuesta E. La hiperglicemia cambia la hidratación del cristalino y produce cambios refractivos transitorios y fluctuantes, que mejoran con estenopeico. No se deben recetar lentes hasta estabilizar la glicemia, porque la refracción volverá a cambiar. Con fondo de ojo normal, corresponde control anual de por vida.

6.02.3.003 Examen visual en adulto

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen visual en el adulto: medir agudeza visual lejana (Snellen a 6 m) y cercana, con y sin corrección, monocular, y con agujero estenopeico si está disminuida; examinar rojo pupilar y reflejos pupilares.
- Desde los 40 años pesquisar presbicia, glaucoma crónico (tonometría y fondo de ojo: excavación >0,5, asimetría >0,2), catarata y degeneración macular; anamnesis de antecedentes familiares de glaucoma, diabetes e hipertensión.
- Presbicia desde los 40–45 años: se corrige con lentes positivos para cerca; dificultad de lejos que mejora con estenopeico indica vicio de refracción.
- Población de riesgo con control periódico: diabéticos (fondo de ojo anual), hipertensos, familiares de glaucoma, miopes altos y trabajadores con riesgo ocular.
- Derivar a oftalmología si hay baja de agudeza visual no corregible, excavación sospechosa, PIO elevada, rojo pupilar alterado o síntomas de alarma (fotopsias, escotomas, dolor).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace unos meses debe alejar el celular y los textos para poder leer, especialmente con poca luz. La agudeza visual de lejos es 20/20 en ambos ojos, el segmento anterior es normal y la presión intraocular es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A) Catarata; cirugía
B) Degeneración macular; antiangiogénicos
C) Miopía; lentes negativos
D) Glaucoma crónico; colirios hipotensores
E) Presbicia; corrección con lentes positivos (convergentes) para visión cercana

Respuesta E. La presbicia es la pérdida de acomodación del cristalino con la edad; desde los 40 a 45 años dificulta la visión cercana y obliga a alejar el texto. Se corrige con lentes positivos para lectura. El examen visual del adulto incluye agudeza visual lejana y cercana y, desde los 40 años, presión intraocular y fondo de ojo.

6.02.3.004 Examen visual preventivo en niños

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje visual del niño: examen del rojo pupilar con oftalmoscopio en el recién nacido y en cada control; reflejo corneal (Hirschberg) y cover test desde los primeros meses; agudeza visual con optotipos desde los 3–4 años (control sano a los 4 años en Chile).
- Derivar si hay leucocoria, rojo pupilar ausente o asimétrico, estrabismo constante o que persiste después de los 6 meses, agudeza visual peor de la esperada para la edad o diferencia ≥2 líneas entre ambos ojos, nistagmo o antecedentes de prematurez/retinopatía.
- Objetivo: detectar ambliopía y estrabismo dentro de la ventana de plasticidad visual (hasta los 7–8 años); después es irreversible. Tratamiento: corrección óptica y parche en el ojo sano (GES estrabismo en menores de 9 años).
- Pesquisa en prematuros: tamizaje de retinopatía del prematuro con fondo de ojo (<1.500 g o <32 semanas).
- Medidas de población: control sano anual, uso de pantallas con moderación y tiempo al aire libre; derivar a oftalmología ante cualquier duda.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de salud de un niño de 4 años, sano, se realiza tamizaje de agudeza visual con cartilla adecuada a su edad. Obtiene 20/40 en el ojo derecho y 20/20 en el izquierdo. El rojo pupilar es simétrico y el test de Hirschberg es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar: a esta edad es normal una diferencia de dos líneas entre ambos ojos
B) Repetir el tamizaje en 2 años, al ingreso escolar
C) Solicitar resonancia magnética de órbitas
D) Indicar parche en el ojo izquierdo sin evaluación previa
E) Derivar a oftalmología para evaluación de ambliopía y vicio de refracción

Respuesta E. En el tamizaje preescolar se deriva si la agudeza es peor de lo esperado para la edad o si hay una diferencia de 2 líneas o más entre ambos ojos, porque sugiere ambliopía por anisometropía. La ambliopía solo es tratable en la ventana de plasticidad visual, por lo que no se debe esperar.

6.02.3.005 Hipertensión arterial

Dónde se enseña: Tema 15.13 Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía hipertensiva: la retina permite ver el daño microvascular de la HTA; fases vasoconstrictora, esclerótica (hilo de cobre, luego de plata) y exudativa. Clasificación de Keith-Wagener-Barker: I estrechamiento arteriolar («hilo de cobre»); II cruces AV patológicos (signos de Gunn y Salus); III hemorragias en llama y exudados algodonosos; IV todo lo anterior más edema de papila bilateral.
- El grado IV define la emergencia hipertensiva maligna (PA habitualmente >200/120, encefalopatía, falla renal): hospitalizar en UCI con labetalol o nitroprusiato EV en infusión continua; bajar la presión arterial media solo 20–25 % en las primeras 2–4 horas, nunca de golpe (ni nifedipino sublingual).
- Grados I–II: ajuste del antihipertensivo oral en APS; grado III: urgencia hipertensiva con ajuste farmacológico rápido y control estrecho, sin necesariamente UCI.
- Complicación frecuente: oclusión de rama venosa o de vena central (hemorragias sectoriales en llama distales a un cruce AV, visión borrosa súbita e indolora); el HTA mal controlada es su principal factor de riesgo; derivar para anti-VEGF/láser.
- Prevención: control estricto de PA, tamizaje con fondo de ojo en hipertensos con repercusión visceral o control deficiente; derivar a oftalmología cuando haya hemorragias, exudados, edema de papila o baja visual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años, hipertenso con mal control, consulta por visión borrosa súbita e indolora en el ojo derecho desde ayer. Al fondo de ojo se observan hemorragias en llama y exudados algodonosos limitados al cuadrante temporal superior, distales a un cruce arteriovenoso, con la vena de ese sector dilatada y tortuosa. Papila sin edema. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía hipertensiva grado IV
B) Oclusión de la arteria central de la retina
C) Retinopatía diabética proliferativa
D) Oclusión de rama venosa retiniana
E) Desprendimiento de retina regmatógeno

Respuesta D. Hemorragias en llama sectoriales, limitadas al territorio drenado por una vena, distales a un cruce arteriovenoso, son una oclusión de rama venosa. La hipertensión arterial es su principal factor de riesgo: la arteriola esclerosada comprime la vena en el cruce. La retinopatía hipertensiva es bilateral y difusa, y el grado IV exige edema de papila.

6.02.3.006 Orbitopatía tiroidea

Dónde se enseña: Tema 7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Orbitopatía tiroidea (de Graves): inflamación autoinmune de grasa y músculos extraoculares, presente en ~50 % de los Graves; proptosis, retracción palpebral (mirada fija), quemosis, ojo seco, diplopía por fibrosis de los rectos, y en graves compresión del nervio óptico. Mixedema pretibial y acropaquia confirman el cuadro.

- El tabaquismo la empeora: suspender el tabaco es parte del tratamiento. Mantener el eutiroidismo (evitar hipo e hipertiroidismo); el radioyodo puede empeorarla y exige prednisona profiláctica.
- Manejo en APS: lágrimas artificiales y ungüento nocturno, elevar la cabecera, lentes oscuros, selenio en formas leves, y derivar a endocrinología y oftalmología para clasificar actividad (CAS) y gravedad.
- Formas moderadas-severas activas: pulsos de metilprednisolona EV (con estudio hepático), radioterapia orbitaria o teprotumumab; urgencia: neuropatía óptica compresiva (baja de visión, discromatopsia, defecto pupilar aferente) o queratopatía por exposición: corticoides EV y descompresión orbitaria.
- Seguimiento: control conjunto endocrino-oftalmológico; cirugía rehabilitadora (descompresión, estrabismo, párpados) cuando la enfermedad está inactiva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 41 años, fumadora de 15 cigarrillos al día, con enfermedad de Graves diagnosticada hace 2 meses, en tratamiento con tiamazol, actualmente eutiroidea. Refiere sensación de arenilla, lagrimeo y retracción palpebral leve bilateral, sin diplopía y con agudeza visual normal. Sin edema de papila ni alteración de la visión de colores. **¿Cuál es la medida que más disminuye el riesgo de progresión de su orbitopatía?**

A) Radioyodo de inmediato para eliminar el hipertiroidismo
B) Suspender completamente el tabaco
C) Descompresión orbitaria quirúrgica
D) Bolos de metilprednisolona endovenosa
E) Aumentar el tiamazol hasta lograr TSH suprimida

Respuesta B. El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable de aparición y progresión de la orbitopatía de Graves. En la orbitopatía leve se indica cesación del tabaco, lubricantes, selenio y mantener el eutiroidismo. El radioyodo puede empeorarla; los corticoides EV se reservan para la forma activa moderada a severa y la descompresión para la neuropatía óptica.

Exámenes e imagenología 2 códigos

6.02.4.001 Campo visual

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual (campimetría computarizada, Humphrey): examen del especialista que mide la sensibilidad retiniana en distintas zonas del campo; el médico general lo interpreta y emplea el informe.
- Indicaciones: sospecha y seguimiento de glaucoma, neuropatías ópticas, enfermedades de la vía óptica (adenoma hipofisario, tumores), retinopatía y evaluación de pérdida visual de causa neurológica.
- Glaucoma: escotomas arciformes (Bjerrum) y escalón nasal que progresan a visión en túnel con conservación de la visión central hasta etapas tardías; el paciente «choca» con objetos laterales aunque lea bien.
- Otros patrones: hemianopsia bitemporal (quiasma, adenoma hipofisario), hemianopsia homónima (lesión retroquiasmática), escotoma central (maculopatía, neuritis óptica), mancha ciega agrandada (papiledema).
- Interpretar: defecto reproducible y progresivo en control seriado confirma daño funcional; combinar siempre con tonometría, fondo de ojo y OCT. Derivar para campimetría ante excavación papilar sospechosa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años con glaucoma crónico de ángulo abierto, con mala adherencia a sus colirios, refiere que choca con objetos que están a sus lados, aunque lee bien. Agudeza visual 20/25 en ambos ojos. Se solicita campimetría computarizada. **¿Cuál es el patrón de campo visual más característico de su enfermedad avanzada?**

A) Escotoma central con pérdida precoz de la visión de lectura
B) Escotomas arciformes que progresan a una visión en túnel, con conservación de la visión central hasta etapas tardías
C) Hemianopsia bitemporal
D) Hemianopsia homónima derecha
E) Metamorfopsia central

Respuesta B. El glaucoma daña las fibras del nervio óptico y produce escotomas arciformes y escalón nasal, que avanzan hacia la periferia hasta dejar solo una isla central: la visión en túnel. Por eso la agudeza visual se conserva hasta muy tarde y la campimetría es clave para el diagnóstico y el seguimiento.

6.02.4.002 Cultivo de secreción conjuntival

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Cultivo de secreción conjuntival: examen que se interpreta y emplea en conjuntivitis neonatal, hiperaguda o gonocócica, crónica o refractaria, en inmunosuprimidos y en postoperatorio.
- Indicaciones prácticas: recién nacido con secreción purulenta abundante (Neisseria gonorrhoeae en 2–5 días; Chlamydia trachomatis a partir de 5–14 días, más escasa), conjuntivitis sin respuesta al antibiótico en 48–72 horas o crónica, uso de lentes de contacto con queratitis.
- Técnica: tomar la muestra antes de iniciar antibiótico, con tórula estéril del fondo de saco conjuntival inferior sin tocar pestañas ni párpado; Gram inmediato, medios para gonococo (agar chocolate) y PCR o inmunofluorescencia para Chlamydia.
- Interpretación: diplococos gramnegativos intracelulares = gonococo (ceftriaxona sistémica); Chlamydia en RN se trata con azitromicina o eritromicina oral y se tratan los padres.
- Emplear el resultado para ajustar antibiótico y estudiar/tratar a la madre y su pareja; derivar de urgencia a oftalmología las formas hiperagudas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 3 días con secreción conjuntival purulenta abundante, bilateral, con edema palpebral marcado y quemosis. La madre no tuvo control prenatal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Lavado con suero y control en 1 semana
B) Masaje del saco lagrimal
C) Colirio de cloranfenicol y alta
D) Tomar Gram y cultivo de secreción conjuntival (incluyendo medios para gonococo y estudio de Chlamydia) e iniciar ceftriaxona sistémica
E) Corticoide tópico

Respuesta D. La conjuntivitis neonatal hiperaguda en los primeros días sugiere Neisseria gonorrhoeae, que puede perforar la córnea. Se toma Gram y cultivo de la secreción (y estudio de Chlamydia, más típica entre los 5 y 14 días) antes de tratar, y se inicia ceftriaxona sistémica con lavados frecuentes. Se estudia y trata a la madre y su pareja.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 14 códigos

6.02.5.001 Aplicación de ungüentos

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: administrar antibióticos en ungüento oftálmico (cloranfenicol, eritromicina) en conjuntivitis bacteriana, blefaritis, protección corneal nocturna o tras curación de abrasiones.

- Técnica: lavado de manos, sentar o acostar al paciente con la cabeza hacia atrás, traccionar suavemente el párpado inferior hacia abajo y depositar una franja de unos 1 cm de ungüento en el fondo de saco conjuntival inferior sin que la punta del tubo toque el ojo ni las pestañas.
- Cerrar suavemente los párpados sin frotar; la visión queda borrosa unos minutos. Si se usan colirios, instilar primero los colirios (esperar 5 minutos) y aplicar el ungüento al final.
- Educar: no compartir el envase, desechar tras el tratamiento, retirar lentes de contacto, completar el esquema (habitualmente 5–7 días).
- Contraindicaciones/derivación: ungüentos con corticoides no se usan sin diagnóstico oftalmológico; derivar si hay dolor, baja de visión o falta de respuesta.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Se indica ungüento oftálmico de cloranfenicol a un paciente con conjuntivitis bacteriana y se le enseña cómo aplicarlo.
> **¿Cuál es la técnica correcta?**
> **A)** Aplicar el ungüento directamente sobre la córnea con la punta del tubo apoyada en el ojo
> **B)** Aplicar sobre la piel del párpado superior
> **C)** Lavarse las manos, traccionar suavemente el párpado inferior hacia abajo, depositar una franja de 1 cm de ungüento en el fondo de saco conjuntival inferior sin tocar el ojo con el tubo, y cerrar suavemente los párpados
> **D)** Frotar el ojo después de aplicarlo para distribuirlo
> **E)** Aplicar antes de los colirios para que actúen mejor
> Respuesta C. El ungüento se aplica con manos limpias en el fondo de saco conjuntival inferior, traccionando el párpado inferior, en una franja de 1 cm, sin que la punta toque el ojo ni las pestañas. Luego se cierra el ojo suavemente, sin frotar. Si se usan colirios, el ungüento va al final, porque impide su absorción.

6.02.5.002 Campo visual por confrontación

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual por confrontación: examen de tamizaje con el examinador y paciente frente a frente a ~1 metro, cada ojo por separado (se ocluye el otro); el paciente fija la nariz del examinador y se compara con el campo propio.
- Técnica: con el brazo extendido, mostrar 1–5 dedos o mover un objeto desde la periferia hacia el centro en los cuatro cuadrantes (superior, inferior, temporal y nasal); el paciente indica cuándo ve los dedos o el objeto. Probar ambos ojos.
- Interpretación: hemianopsia bitemporal (compresión del quiasma, adenoma hipofisario con choque con muebles o autos), hemianopsia homónima (lesión retroquiasmática), pérdida concéntrica (glaucoma avanzado), escotoma central o altitudinal.
- Es un examen de pesquisa: no reemplaza la campimetría computarizada, pero permite sospechar lesiones del quiasma, vía óptica y glaucoma y derivar.
- Ante defecto campimétrico: solicitar resonancia de silla turca/cerebro y perfil hormonal si hay hemianopsia bitemporal, y derivar a oftalmología y neurología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años con cefalea de meses y choques frecuentes con objetos a ambos lados. Al examinar el campo visual por confrontación, sentado frente a él a 1 metro, el paciente no detecta los dedos del examinador en las mitades temporales de ambos campos visuales. **¿Qué lesión sugiere este hallazgo?**

A) Lesión del quiasma óptico, como un macroadenoma hipofisario
B) Lesión del nervio óptico derecho
C) Lesión de la cintilla óptica izquierda
D) Lesión del lóbulo occipital derecho
E) Glaucoma crónico

Respuesta A. El campo visual por confrontación compara el campo del paciente con el del examinador, cada ojo por separado y por cuadrantes. La hemianopsia bitemporal indica compresión del quiasma (cruce de fibras nasales), típicamente por macroadenoma hipofisario o craneofaringioma; se estudia con resonancia selar y campimetría computarizada. Las lesiones retroquiasmáticas dan hemianopsias homónimas.

6.02.5.003 Colocación de sello ocular

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Sello ocular (oclusión): protege el ojo, alivia el dolor y facilita el traslado en abrasiones corneales o tras extraer un cuerpo extraño; se coloca con el párpado cerrado.
- Técnica: cerrar el párpado, colocar una o dos gasas dobladas sobre el ojo y fijar con 2–3 cintas adhesivas oblicuas desde la frente al pómulo, firme pero sin presionar el globo.
- Si se sospecha globo abierto o perforación NO se coloca sello compresivo: se usa una concha rígida fenestrada apoyada en el reborde óseo, sin tocar el ojo.
- Contraindicado en usuarios de lentes de contacto (riesgo de infección por Pseudomonas), en úlceras o infecciones corneales (el parche favorece el crecimiento bacteriano) y no reemplaza la irrigación en causticaciones.
- No mantener más de 24 horas sin control; indicar acudir si aumenta el dolor o la visión empeora.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años, soldador, consulta en el SAPU por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Se le extrae un cuerpo extraño corneal superficial y la tinción con fluoresceína muestra una erosión corneal de 2 mm. No usa lentes de contacto. Se decide ocluir el ojo para su traslado y comodidad. **Respecto de la colocación del sello ocular, ¿cuál afirmación es correcta?**

A) Se debe ocluir con el ojo abierto para permitir la salida de lágrimas
B) Se recomienda en usuarios de lentes de contacto con erosión corneal
C) Está indicado en toda causticación ocular antes de irrigar
D) Se pone con el párpado cerrado, gasas sobre el ojo y tela adhesiva oblicua desde la frente al pómulo, sin presionar el globo si se sospecha perforación
E) Debe mantenerse al menos 7 días sin retirarlo

Respuesta D. El sello se coloca con el párpado cerrado, gasa doblada sobre el ojo y cintas adhesivas oblicuas de frente a pómulo, firme pero sin presión si existe riesgo de perforación (en ese caso, concha rígida). Está contraindicado en usuarios de lentes de contacto por riesgo de Pseudomonas y nunca reemplaza la irrigación en causticaciones.

6.02.5.004 Cover test

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Cover test (prueba de oclusión): permite detectar y clasificar estrabismo manifiesto (tropia). Se pide al niño fijar un objeto y se tapa un ojo mientras se observa el movimiento del otro.
- Interpretación: si el ojo descubierto se mueve para tomar la fijación estaba desviado: movimiento de afuera hacia adentro = exotropia; de adentro hacia afuera = endotropia; sin movimiento al ocluir cada ojo = ortotropia. El cover alternante pesquisa forias.

- Técnica: fijación a 33 cm y 6 metros, luz y atención del niño, ocluir con la mano o paleta durante 2–3 segundos, repetir con el otro ojo; complementa el test de Hirschberg.
- Todo estrabismo o duda en un niño se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía; no usar parches sin evaluación previa.
- Realizar en controles de salud desde los 6 meses; en <6 meses el estrabismo intermitente puede ser fisiológico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 3 años; los padres notan que a veces "se le va un ojo". El reflejo corneal es simétrico. Al realizar el cover test, al tapar el ojo izquierdo, el ojo derecho no se mueve; al tapar el ojo derecho, el ojo izquierdo hace un movimiento de afuera hacia adentro para fijar. **¿Cuál es la interpretación del examen?**

A) Examen normal
B) Exotropia del ojo izquierdo (estrabismo divergente); derivar a oftalmología
C) Endotropia del ojo izquierdo
D) Pseudoestrabismo por epicanto
E) Exotropia del ojo derecho

Respuesta B. En el cover test (oclusión unilateral) se tapa un ojo y se observa el otro: si el ojo descubierto se mueve para tomar la fijación, estaba desviado. Un movimiento de afuera hacia adentro indica que estaba desviado hacia afuera (exotropia); de adentro hacia afuera, endotropia. Todo estrabismo en un niño se deriva por riesgo de ambliopía.

6.02.5.005 Eversión palpebral

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Eversión palpebral: maniobra para ver la conjuntiva tarsal superior, donde se alojan cuerpos extraños, papilas (alergia) y folículos; se indica ante sensación de cuerpo extraño, erosiones corneales lineales verticales y ojo rojo con fluoresceína positiva.
- Técnica: pedir al paciente mirar hacia abajo, tomar las pestañas del párpado superior con una mano, apoyar un aplicador de algodón sobre el borde superior del tarso, y traccionar hacia arriba y adelante para voltear el párpado (como una «página»); mantener evertido mientras se examina.
- Hallazgos: cuerpo extraño adherido a la conjuntiva tarsal, papilas en empedrado (conjuntivitis alérgica/vernal), folículos (viral, tracoma) o cicatrización.
- Contraindicado en sospecha de herida penetrante o globo abierto, o en trauma severo (no presionar el globo).
- Si hay cuerpo extraño, retirarlo con un hisopo húmedo bajo anestesia tópica y luego indicar antibiótico tópico; el médico general realiza el procedimiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 91

Paciente de 50 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo izquierdo desde ayer, asociado a dolor, blefaroespasmo y fotofobia. Por el dolor, el examen es dificultoso, por lo que se administra anestésico local; se aprecia ojo rojo y, al aplicar fluoresceína, se tiñen múltiples erosiones lineales verticales en la mitad superior de la córnea. **¿Cuál es la conducta más apropiada en este caso?**

A) Evertir el párpado superior
B) Aplicar colirio de gentamicina
C) Poner parche ocular y controlar
D) Aplicar colirio con atropina
E) Realizar aseo local

Respuesta A. Erosiones corneales lineales verticales en la mitad superior sugieren un cuerpo extraño alojado en la conjuntiva tarsal superior, que raspa la córnea con cada parpadeo. Se debe evertir el párpado superior para buscarlo y extraerlo con hisopo húmedo. Luego se indica antibiótico tópico. El parche sin retirar el cuerpo extraño perpetúa el daño.

6.02.5.006 Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen del rojo pupilar (test de Brückner): con oftalmoscopio directo a unos 50 cm a 1 metro, en penumbra, iluminando ambos ojos a la vez; se compara el reflejo rojo anaranjado de las pupilas.
- Normal: reflejo rojo simétrico y brillante. Anormal: reflejo ausente, blanco (leucocoria), amarillento o asimétrico; en adultos, reflejo atenuado o con manchas oscuras indica catarata.
- Indicación: en todo recién nacido y en cada control del lactante y del preescolar, y en adultos con baja de visión (catarata).
- Leucocoria o asimetría exige derivación urgente a oftalmología para descartar retinoblastoma, catarata congénita, retinopatía del prematuro o desprendimiento de retina; la catarata congénita debe operarse precozmente para evitar ambliopía profunda.
- Es un examen que el médico general realiza: no tranquilizar ante reflejo anormal ni esperar al próximo control.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de un lactante de 2 meses se realiza el examen del rojo pupilar con oftalmoscopio directo a 50 cm, en penumbra, iluminando ambos ojos simultáneamente (test de Brückner). El ojo derecho muestra rojo pupilar normal y el izquierdo un reflejo blanco. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el examen en el próximo control a los 6 meses
B) Tranquilizar, porque es normal en lactantes
C) Indicar colirio antibiótico
D) Derivación urgente a oftalmología por leucocoria (descartar catarata congénita y retinoblastoma)
E) Solicitar ecografía cerebral

Respuesta D. El rojo pupilar se examina en todo recién nacido y en los controles de salud. Un reflejo ausente, blanco (leucocoria) o asimétrico obliga a derivación urgente a oftalmología para descartar catarata congénita (que debe operarse precozmente para evitar ambliopía profunda), retinoblastoma, retinopatía del prematuro u otras causas.

6.02.5.007 Extracción de cuerpo extraño tarsal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuerpo extraño tarsal: partícula alojada en la conjuntiva tarsal superior que provoca arenilla, lagrimeo y erosiones corneales lineales verticales que se tiñen con fluoresceína (típicas de la mitad superior de la córnea).
- Técnica: instilar anestésico tópico, evertir el párpado superior, localizar la partícula y retirarla con un hisopo de algodón humedecido en suero fisiológico con un barrido suave.
- Si el cuerpo extraño está incrustado en la córnea, no intentar con el hisopo: derivar a oftalmología; sospechar globo abierto o cuerpo extraño intraocular si hubo alta velocidad.
- Después del retiro: antibiótico tópico (ungüento o colirio) y control a las 24–48 horas; no dar anestésico tópico para uso en domicilio ni corticoides, y no ocluir en usuarios de lentes de contacto.
- El médico general realiza el procedimiento; derivar si persiste dolor, hay úlcera corneal, óxido residual o baja de visión.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con sensación de arenilla en el ojo derecho tras andar en bicicleta. Al evertir el párpado superior se observa una partícula negra adherida a la conjuntiva tarsal. La córnea muestra erosiones lineales superficiales con fluoresceína. **¿Cuál es la técnica de extracción más adecuada?**

A) Extraer con una aguja de calibre 18 sin anestesia
B) Lavar con agua de la llave y no evertir
C) Bajo anestesia tópica, retirar la partícula con un hisopo de algodón humedecido en suero, luego indicar antibiótico tópico
D) Dejar que salga sola con el parpadeo y control en 48 horas
E) Indicar corticoide tópico y parche

Respuesta C. El cuerpo extraño tarsal superior se extrae evirtiendo el párpado y barriéndolo con un hisopo de algodón húmedo, tras anestesia tópica. Las agujas se reservan para cuerpos extraños corneales incrustados y en manos entrenadas. Después se indica antibiótico tópico y se controla la erosión corneal. Los corticoides tópicos y el uso de anestésico como tratamiento están contraindicados.

6.02.5.008 Extracción de pestañas distiquiásicas

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Distiquiasis: pestañas aberrantes que nacen del borde posterior del párpado, de los orificios de las glándulas de Meibomio, y se dirigen hacia el globo; se asocia a blefaritis crónica, tracoma, cicatrices o quemaduras químicas.
- Cuadro: sensación de cuerpo extraño crónico, ojo rojo, lagrimeo y fotofobia; con lupa se ven las pestañas rozando la córnea y tinción con fluoresceína punteada (erosiones, úlceras o leucomas).
- Manejo inicial en APS: lubricantes (lágrimas artificiales o ungüento) y protección de la córnea; la extracción con pinza solo la hace el especialista.
- Como las pestañas vuelven a crecer en semanas, el tratamiento definitivo destruye el folículo (electrólisis, crioterapia, láser o cirugía) y lo indica oftalmología. No cortar con tijera (la punta rígida daña más).
- Derivar a oftalmología; urgente si hay úlcera corneal, dolor intenso o baja de visión.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 60 años con sensación de cuerpo extraño crónico y ojo rojo derecho. Al examen con lupa se observan 3 pestañas que nacen desde la línea de las glándulas de Meibomio, dirigidas hacia el globo ocular, rozando la córnea, que muestra erosiones puntiformes con fluoresceína. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**
>
> **A)** Antibiótico tópico crónico
> **B)** Cortar las pestañas con tijera a ras de piel
> **C)** Corticoide tópico
> **D)** Parche ocular permanente
> **E)** Depilación (extracción) de las pestañas aberrantes con pinza y lubricación; derivar para tratamiento definitivo (electrólisis, crioterapia) si recurren
>
> Respuesta E. La distiquiasis (pestañas que nacen de los orificios de las glándulas de Meibomio) roza la córnea y causa erosiones, úlceras y leucomas. El manejo inicial es depilar con pinza bajo lupa y lubricar; como vuelven a crecer en semanas, el tratamiento definitivo destruye el folículo (electrólisis, crioterapia o cirugía). Cortarlas deja una punta rígida dañina.

6.02.5.009 Instilación de colirios

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: administrar colirios (antibióticos, antiglaucomatosos, lubricantes, antihistamínicos, midriáticos) en forma correcta y enseñar la técnica al paciente.
- Técnica: lavado de manos, cabeza hacia atrás mirando hacia arriba, traccionar suavemente el párpado inferior, instilar 1 gota en el fondo de saco conjuntival inferior sin tocar el ojo ni las pestañas con el gotario (el saco solo retiene una gota; más gotas rebasan).
- Cerrar suavemente los ojos y ocluir el punto lagrimal (presión del canto interno) 1–2 minutos para aumentar el contacto y reducir la absorción sistémica (broncoespasmo y bradicardia con timolol). No parpadear con fuerza.
- Si se usan varios colirios, esperar 5 minutos entre uno y otro; los ungüentos van al final; retirar lentes de contacto antes de aplicar; no compartir los frascos y desechar al mes de abierto.
- Precauciones: no usar midriáticos en ángulo estrecho no tratado, ni corticoides sin diagnóstico; betabloqueadores tópicos contraindicados en asma y bloqueo AV.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con glaucoma crónico y asma leve inicia timolol en colirio. Se le enseña la técnica de instilación. **¿Cuál es la técnica que además reduce la absorción sistémica del fármaco?**

A) Instilar 3 gotas para asegurar el efecto
B) Aplicar 2 colirios distintos al mismo tiempo
C) Parpadear rápidamente varias veces tras la instilación
D) Instilar directamente sobre la córnea con el gotario apoyado
E) Instilar 1 gota en el fondo de saco inferior y luego cerrar los ojos y presionar el canto interno (oclusión del punto lagrimal) durante 1 a 2 minutos

Respuesta E. Se instila 1 gota (el fondo de saco solo retiene una) traccionando el párpado inferior, sin tocar el ojo. Luego se cierran los ojos y se comprime el canto interno 1 a 2 minutos: aumenta el contacto y disminuye el paso a la mucosa nasal, reduciendo efectos sistémicos como broncoespasmo y bradicardia por betabloqueadores.

6.02.5.010 Oftalmoscopía directa

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG · Tema 15.13 Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

QUÉ HAY QUE SABER

- Oftalmoscopía directa: examen de fondo de ojo con oftalmoscopio en una habitación en penumbra, acercándose al ojo del paciente (a ~2 cm) con el ojo derecho del examinador para el ojo derecho del paciente; con pupila dilatada se amplía el campo (evitar dilatar si hay riesgo de ángulo estrecho).
- Qué evaluar: reflejo rojo, papila (bordes, color, relación excavación/papila: sospecha de glaucoma si >0,5 o asimetría >0,2), vasos retinianos (cruces AV, calibre), mácula y retina periférica posible.
- Hallazgos clave: edema de papila bilateral (hipertensión intracraneal o retinopatía hipertensiva grado IV); hemorragias, exudados y neovasos (retinopatía diabética o hipertensiva); mancha rojo cereza (oclusión arterial); retina pálida y desprendida; papila excavada (glaucoma).
- Indicado en diabéticos (tamizaje anual), hipertensos, cefalea con sospecha de hipertensión endocraneana, baja de visión y sospecha de glaucoma.
- Es un procedimiento que el médico general realiza; si hay hallazgos patológicos, se deriva a oftalmología para oftalmoscopía indirecta, OCT o retinografía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. **¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A) Grado I
B) Grado II
C) Grado III
D) Grado IV
E) Retinopatía proliferativa grado B

Respuesta B. Cruces arteriovenosos patológicos (signo de Gunn o de Salus), junto con esclerosis arteriolar, sin hemorragias, exudados ni edema de papila, definen el grado II de Keith-Wagener-Barker. El grado I solo tiene estrechamiento arteriolar; el grado III añade hemorragias y exudados; el grado IV suma edema de papila.

6.02.5.011 Reflejos pupilares

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflejos pupilares: fotomotor directo y consensual (vía aferente por nervio óptico, eferente por III par), acomodativo y prueba de la linterna oscilante; examinar en penumbra, con luz uniforme y fijación a distancia.
- Defecto pupilar aferente relativo (Marcus Gunn): al pasar la luz del ojo sano al enfermo ambas pupilas se dilatan paradójicamente; signo más sensible de lesión asimétrica del nervio óptico (neuritis óptica, glaucoma avanzado,

oclusión arterial) o retina extensa.
- Lesión eferente del III par: pupila dilatada que no reacciona a la luz directa ni consensual, con ptosis y ojo abajo y afuera; con cefalea sospechar aneurisma de comunicante posterior. Midriasis media fija con dolor y ojo pétreo: glaucoma agudo. Miosis hiporreactiva: uveítis anterior. Horner: miosis, ptosis y anhidrosis. Pupila tónica de Adie: grande y de respuesta lenta.
- Pupilas mióticas puntiformes en intoxicación por opioides u organofosforados; midriasis en anticolinérgicos o muerte encefálica.
- El médico general realiza el examen; derivar de urgencia anisocoria nueva con ptosis, cefalea, trauma o baja visual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años consulta por caída del párpado derecho y visión doble de 1 día de evolución, con cefalea intensa. Al examen, el ojo derecho está desviado hacia abajo y afuera, con ptosis completa. La pupila derecha mide 7 mm y no reacciona a la luz directa ni consensual; la pupila izquierda mide 3 mm y reacciona a la luz directa y consensual. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de estos hallazgos?**

A) Defecto pupilar aferente relativo derecho por neuritis óptica
B) Síndrome de Horner derecho
C) Lesión eferente del tercer par derecho, sospechar aneurisma de comunicante posterior
D) Pupila de Argyll Robertson
E) Anisocoria fisiológica

Respuesta C. Si la pupila afectada no responde ni a la luz directa ni a la consensual, el defecto es eferente (tercer par). Un tercer par con midriasis y cefalea obliga a descartar aneurisma de comunicante posterior con angio-TC urgente. En el defecto aferente, la pupila sí contrae con la luz del ojo sano.

6.02.5.012 Tensión ocular palpatoria

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

QUÉ HAY QUE SABER

- Tensión ocular palpatoria: estimación grosera de la presión intraocular cuando no hay tonómetro; útil en sospecha de glaucoma agudo (ojo pétreo) o de herida/perforación (ojo blando).
- Técnica: paciente con la mirada hacia abajo y los párpados cerrados; apoyar ambos índices sobre el párpado superior y presionar suave y alternadamente sobre el globo, comparando con el otro ojo.
- Interpretación: un ojo duro como piedra, asimétrico respecto al otro, apoya glaucoma agudo; un ojo muy blando sugiere herida penetrante o ruptura del globo.
- Contraindicado en sospecha de perforación ocular, trauma abierto, hifema o úlcera corneal profunda (no presionar el globo); nunca presionar la córnea ni mantener la presión por tiempo prolongado.
- No mide mmHg: derivar para tonometría. Ante ojo pétreo con síntomas, iniciar hipotensores (manitol, acetazolamida, timolol) y derivar de urgencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 66 años, hipermétrope, consulta en un servicio de urgencia sin tonómetro por dolor ocular izquierdo intenso, náuseas y visión de halos alrededor de las luces. Se decide estimar la presión intraocular por palpación bidigital. **¿Cuál es la técnica e interpretación correctas?**

A) Con la paciente mirando hacia abajo y los ojos cerrados, palpar alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando con el otro ojo; un ojo duro como piedra sugiere presión muy elevada
B) Con la paciente mirando hacia arriba, presionar directamente la córnea con ambos índices
C) Presionar el globo ocular con fuerza durante 1 minuto para evaluar el reflejo oculocardíaco
D) Palpar el párpado inferior con la paciente mirando hacia arriba; un ojo blando sugiere glaucoma agudo
E) La palpación permite medir la presión exacta en milímetros de mercurio

Respuesta A. La tensión ocular palpatoria se realiza con la mirada hacia abajo y los párpados cerrados, presionando suave y alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando ambos ojos. Es solo una estimación grosera: un ojo duro como piedra, asimétrico respecto al otro, apoya un glaucoma agudo. Nunca se presiona la córnea.

6.02.5.013 Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea): se ilumina con una linterna a 30–40 cm de la cara mientras el niño fija la luz, y se observa la posición del reflejo corneal en ambas pupilas.
- Normal: reflejo centrado y simétrico (levemente nasal, 0–0,5 mm). Si el reflejo está desplazado hacia temporal, el ojo está desviado hacia adentro (endotropia); si está hacia nasal, desviado hacia afuera (exotropia). Cada mm de desplazamiento equivale a unos 7° (15 dioptrías prismáticas).
- Útil para tamizaje de estrabismo en lactantes y niños que no colaboran; no detecta forias ni desviaciones pequeñas (completar con cover test). Descartar pseudoestrabismo por epicanto (reflejo simétrico).
- Ante asimetría se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía (ventana hasta 7–8 años); asociar examen del rojo pupilar.
- El médico general realiza el test en cada control infantil desde los 6 meses.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 2 años en control sano. Se ilumina con una linterna desde 30 cm frente a su cara mientras fija la luz. En el ojo derecho el reflejo luminoso corneal está centrado en la pupila; en el ojo izquierdo está desplazado hacia el borde temporal de la pupila. **¿Cuál es la interpretación?**

A) Endotropia (estrabismo convergente) del ojo izquierdo
B) Normal
C) Exotropia del ojo izquierdo
D) Hipertropia del ojo derecho
E) Ambliopía sin estrabismo

Respuesta A. En el test de Hirschberg el reflejo corneal debe estar centrado y simétrico. Si en un ojo el reflejo está desplazado hacia temporal, la córnea apunta hacia nasal: endotropia; si está desplazado hacia nasal, exotropia. Cada milímetro de desplazamiento equivale a unos 7 grados de desviación. Ante asimetría se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía.

6.02.5.014 Toma de visión

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Toma de visión (agudeza visual): se realiza de manera monocular con tabla de Snellen o de optotipos a 6 metros, con buena iluminación, cubriendo el otro ojo sin presionarlo; primero sin corrección y luego con lentes si los usa.
- Registrar la línea más pequeña leída (20/20 normal; 20/40, etc.); en niños usar optotipos adecuados a la edad (E de Snellen, figuras); a los 5 años se espera 20/30 a 20/20.
- Si la AV está disminuida, repetir con agujero estenopeico: mejora = vicio de refracción; no mejora = lesión orgánica (catarata, maculopatía, neuritis) o ambliopía.
- Una diferencia de 2 o más líneas entre ambos ojos es anormal en niños (ambliopía por anisometropía) y obliga a derivar; en adultos, baja brusca de visión es urgencia.
- Es un examen básico que el médico general debe realizar y registrar en cada control (adulto y niño).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 5 años en control de salud escolar. Se toma la agudeza visual con tabla de Snellen (optotipos) a 6 metros, con buena iluminación, cada ojo por separado. Resultado: ojo derecho 20/20 y ojo izquierdo 20/50; con agujero estenopeico el ojo izquierdo mejora a 20/25. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A) Normal para la edad; control en 2 años
B) Disminución de agudeza visual del ojo izquierdo probablemente por vicio de refracción, con diferencia de 2 o más líneas entre ojos; derivar a oftalmología para refracción por riesgo de ambliopía
C) Ambliopía irreversible; no requiere estudio
D) Catarata; derivar para cirugía
E) Repetir la toma con ambos ojos abiertos

Respuesta B. La agudeza visual se toma monocularmente a la distancia indicada. A los 5 años se espera 20/30 a 20/20; una diferencia de 2 o más líneas entre ojos es anormal. La mejoría con agujero estenopeico indica un vicio de refracción corregible. Por el riesgo de ambliopía (anisometropía), se deriva para refracción y corrección óptica.